

جامعة قسنطينة 2

كلية العلوم الاقتصادية

مطبوعة بيداغوجية في مقياس

النظام الصحي الجزائري ونظام الحماية الاجتماعية

(AHSSP)

محاضرات السداسي الثاني لطلبة السنة الأولى طب

إعداد: د. فريد خلاطو

مقدمة المطبوعة

تندرج هذه المطبوعة في إطار مقياس النظام الصحي الجزائري ونظام الحماية الاجتماعية (AHSSP)، الموجه لطلبة السنة الأولى طب في السداسي الثاني. وهي لا تقدم المادة بوصفها عرضاً تاريخياً عاماً فقط، بل بوصفها مدخلاً لفهم العلاقة بين الصحة والسياسة العامة والاقتصاد والحماية الاجتماعية في الجزائر. فالنظام الصحي لا يتكون من مستشفيات وأطباء وتجهيزات فحسب، بل من اختيارات عمومية، وآليات تمويل، وقواعد تنظيمية، ومسارات رعاية، وموارد بشرية، ومؤسسات حماية اجتماعية تتفاعل جميعاً لتحديد قدرة المواطن على الوصول الفعلي إلى العلاج.

تتعلق المطبوعة من البرنامج الرسمي للمقياس، الذي يربط بين الجذور التاريخية للنظام الصحي الجزائري والتحولات التنظيمية والمالية والوبائية التي عرفها منذ الاستقلال. لذلك تم ترتيب المحاضرات الثماني وفق التسلسل المعتمد في البرنامج: الوضع الصحي والسياسة الصحية خلال الستينيات، الحاجات التي أدت إلى مجانية العلاج سنة 1974، التطور المخطط للرعاية الصحية خلال الثمانينيات، هيكل وتنظيم النظام الصحي، النظام الصحي العمومي منذ 2007، الموارد البشرية الصحية، نفقات الصحة وآليات التمويل، ثم رؤية 2030 لتطوير قطاع الصحة.

تكمن أهمية هذه المطبوعة في أنها تساعد الطالب على الانتقال من الحفظ الوصفي إلى الفهم التحليلي. فدراسة النظام الصحي الجزائري تقتضي التساؤل عن أسباب ضعف التغطية الصحية بعد الاستقلال، وعن دوافع مجانية العلاج، وعن جدوى الاستثمار في الوقاية والرعاية الأولية، وعن العلاقة بين الهرم الصحي والضمان الاجتماعي، وعن أثر التحول الديموغرافي والوبائي على الطلب على الرعاية المتخصصة. كما تقتضي دراسة الموارد البشرية والتمويل الصحي لفهم أن جودة الخدمة لا تتوقف على النصوص القانونية وحدها، بل على قدرة النظام على تعبئة الموارد وتوزيعها وتنسيق استعمالها.

اعتمدت المطبوعة مقاربة بيداغوجية موحدة تقوم على تقديم بطاقة موجزة لكل محاضرة، أهداف تعليمية، مفاهيم مفتاحية، مطلبين أو محاور كبرى مطابقة للبرنامج الرسمي، تركيب تحليلي، حالة تطبيقية، وأسئلة مع حل نموذجي مقترح. وتهدف هذه البنية إلى تسهيل استعمال المطبوعة في التدريس، والمراجعة، والتحضير للامتحان، وفي الوقت نفسه تدريب الطالب على توظيف مفاهيم اقتصاد الصحة مثل الندرة، الكفاءة، الإنصاف، التكاليف غير المباشرة، الإنفاق المباشر من الجيب، الاستدامة المالية، والتنسيق بين مستويات الرعاية.

تم الحرص كذلك على إدراج الإحالات المرجعية داخل المتن ، وقد استندت المعالجة إلى البرنامج الرسمي للمقياس، وإلى القانون الصحي الجزائري، وإلى مراجع داعمة حول النظام الصحي في الجزائر والمغرب العربي، والتحوليات الصحية والديموغرافية، ونفقات الصحة، ورؤية 2030. والغاية من ذلك هي ربط الخطاب البيداغوجي بسند علمي ومؤسسي واضح، دون إغفال المحاضرات بإحالات غير ضرورية.

وعليه، فإن هذه المطبوعة لا ينبغي أن تُقرأ كملخص لمحاضرات منفصلة، بل كمسار واحد يشرح كيف انتقل النظام الصحي الجزائري من مرحلة بناء الحد الأدنى من التغطية بعد الاستقلال إلى مرحلة البحث عن الجودة، الاستدامة، الإنصاف، والجاهزية المستقبلية. ومن ثم فهي تمهد للطالب لفهم أن كل إصلاح صحي يجب أن يوازن بين حق المواطن في العلاج، وندرة الموارد، وعدالة التوزيع، وكفاءة التنظيم، وقدرة الدولة والضمان الاجتماعي والأسر على تحمل تكاليف الرعاية.

البرنامج الرسمي للمقياس

رقم الفصل	عنوان الفصل بالعربية	مطالب الفصل كما في البرنامج الرسمي
1	الصحة والسياسة الصحية خلال الستينيات	الوضع الصحي في الجزائر عند الاستقلال؛ طبيعة النظام الصحي الموروث ونقاط ضعفه.
2	الحاجات الصحية التي أدت إلى إدخال مجانية الطب سنة 1974	حاجات الممارسين وغياب هياكل التكوين؛ التعاون الدولي لتوظيف الممارسين الصحيين.
3	التطور المخطط لتوفير الرعاية الصحية العامة خلال الثمانينيات	تطوير الرعاية الوقائية؛ توسيع مرافق الرعاية الصحية الأولية.
4	هيكل وتنظيم النظام الصحي الجزائري	نظام صحي ذو شكل هرمي؛ تغطية شاملة للتأمين الاجتماعي.

5	النظام الصحي العمومي منذ سنة 2007	آثار التحول الديموغرافي والوبائي؛ نمو الطلب على الرعاية المتخصصة واللامركزية الضرورية.
6	الموارد البشرية في قطاع الصحة: القضايا الرئيسية والتحديات	الحاجة الكبيرة إلى الأطباء الأخصائيين والتوزيع الجغرافي غير المتوازن؛ نظام صحي يعمل بقطاع عام وقطاع خاص ضعيفي التنسيق.
7	نفقات الصحة وآليات التمويل	إصلاح الضمان الاجتماعي لسنة 1983؛ نمو نفقات الصحة وصعوبة التحكم فيها والإنفاق المباشر من الجيب.
8	رؤية 2030 لتطوير قطاع الصحة في الجزائر	ما النظام الصحي المتوقع في أفق 2030؟؛ كيفية تكيف عرض الرعاية الصحية مع آثار الشيخوخة وعبء الأمراض المستحثة.

المحاضرة الأولى: الصحة والسياسة الصحية في الجزائر خلال الستينيات

تمثل هذه المحاضرة نقطة الانطلاق لفهم نشأة السياسة الصحية في الجزائر، لأنها تعود بالطالب إلى السنوات الأولى بعد الاستقلال حيث كان النظام الصحي في وضع تأسيس صعب. فالحديث عن الصحة في الستينيات لا يتعلق فقط بوصف الأمراض المنتشرة أو عدد المؤسسات الصحية، بل بفهم السياق العام الذي كانت فيه الدولة الجديدة مطالبة ببناء إدارة صحية وطنية، وتوفير الحد الأدنى من الرعاية، وتقليص الفوارق بين المدن والمناطق الداخلية والريفية.

يساعد هذا التمهيد على إدراك أن ضعف الوضع الصحي آنذاك كان نتيجة تفاعل عوامل متعددة: إرث مؤسسي غير متوازن، نقص حاد في الممارسين الصحيين، محدودية الوقاية، وانتشار الفقر والأمراض المعدية. ومن ثم فإن السياسة الصحية الأولى لم تكن اختياراً قطاعياً معزولاً، بل جزءاً من مشروع بناء الدولة الاجتماعية وتوسيع حضورها في حياة المواطنين.

ينبغي أن يقرأ الطالب هذه المحاضرة باعتبارها مدخلاً لفهم بقية المحاضرات. فمشكلات الندرة، والعدالة المجالية، والتغطية الصحية، والرعاية الأولية، ستظهر لاحقاً في موضوعات مجانية العلاج، التخطيط الصحي، الموارد البشرية، والتمويل. لذلك يركز الدرس على العلاقة بين الوضع الصحي الموروث وبين الحاجة إلى اختيارات عمومية جديدة تعيد توجيه النظام نحو الوقاية والإنصاف.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	التفصيل
المقياس	النظام الصحي الجزائري ونظام الحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب – السداسي الثاني
الموقع داخل البرنامج	الفصل 1: الصحة والسياسة الصحية خلال الستينيات
الفكرة المركزية	فهم الوضع الصحي الموروث عند الاستقلال بوصفه نقطة الانطلاق التاريخية لتشكل السياسات الصحية الجزائرية اللاحقة.

ثانياً: الأهداف التعليمية

- أن يصف الطالب الوضع الصحي في الجزائر عند الاستقلال من حيث الأمراض والوفيات والموارد.
- أن يفسر طبيعة النظام الصحي الموروث عن المرحلة الاستعمارية وأوجه ضعفه.
- أن يربط بين الاختلالات الصحية الأولى وبين الحاجة إلى بناء سياسة صحية وطنية.
- أن يطبق مفاهيم الندرة والتوزيع الجغرافي والإنصاف على وضعية الستينيات.

ثالثاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
---------	----------------

الوضع الصحي	حالة السكان من حيث المرض والوفيات والتغذية والوصول إلى العلاج.
النظام الصحي الموروث	نظام تركزت خدماته في المدن الكبرى ولم يكن موجهاً لتغطية كل السكان بعدالة.
الأمراض المعدية	انتشار أمراض مثل السل والمالاريا والأمراض المعوية نتيجة ضعف الوقاية والتغطية.
الفجوة الجغرافية	عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية بين المدن والسواحل من جهة والريف والداخل والجنوب من جهة أخرى.
الرعاية الصحية الأولية	الخدمات الأساسية القريبة من السكان مثل الوقاية والتلقيح والمتابعة الأولية.

رابعاً: مدخل تحليلي

يمهد هذا الدرس لفهم العلاقة بين الإرث التاريخي والاختيارات الصحية اللاحقة. فالوضع الصحي عند الاستقلال لم يكن مجرد نقص في عدد المستشفيات، بل كان نتيجة تراكم طويل من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضعف الوقاية، وغياب شبكة صحية وطنية موجهة لجميع السكان. ولذلك فإن تحليل الستينيات يساعد الطالب على إدراك أن بناء النظام الصحي الجزائري بدأ من معالجة أزمة تأسيسية شملت المرض، الندرة، والتنظيم.

تُقرأ هذه المحاضرة أيضاً من زاوية اقتصاد الصحة: عندما تكون الموارد الطبية محدودة ومتمركزة في المدن، تصبح المسافة والفقر ونقص المعلومات عوامل تحدد فرص العلاج مثلها مثل المرض نفسه. ومن ثم فإن دراسة هذه المرحلة تكشف مبكراً مفاهيم أساسية ستكرر في بقية المطبوعة، مثل الإنصاف الصحي، الرعاية الأولية، والاختيار بين العلاج والوقاية.

يمثل عقد الستينيات لحظة تأسيسية في تاريخ النظام الصحي الجزائري. فقد خرجت الجزائر من الاستعمار بنظام صحي محدود، غير متوازن، وضعيف القدرة على الاستجابة لحاجات السكان. كانت الأولوية الصحية آنذاك مرتبطة بمواجهة الأمراض المعدية، خفض وفيات الأطفال، توفير حد أدنى من الكوادر الطبية، وبناء إدارة صحية وطنية قادرة على التخطيط والتوزيع العادل للموارد (IPEMED, 2012). Institut National de Santé ؛

Brahamia, 2022): Publique / Projet TAHINA, 2007

خامساً: المبحث الأول: الوضع الصحي في الجزائر عند الاستقلال

عند الاستقلال سنة 1962 ، واجهت الجزائر وضعاً صحياً هشاً تميز بارتفاع وفيات الأطفال، انتشار الأمراض المعدية، سوء التغذية، وضعف الوقاية. لم تكن المشكلة طبية فقط، بل كانت اجتماعية واقتصادية أيضاً، لأن المرض كان مرتبطاً بالفقر، السكن غير الصحي، نقص المياه الصالحة للشرب، وضعف الوصول إلى المرافق الصحية (IPEMED, 2012)؛ Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ (Brahamia, 2022)

- ارتفاع وفيات الأطفال والرضع بسبب ضعف التلقيح وسوء التغذية ونقص المتابعة الصحية (IPEMED, 2012)؛ Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ (Brahamia, 2022)
- انتشار أمراض معدية مثل السل والمالاريا والجذري والأمراض المعوية.

• ندرة الأطباء والممرضين، وتركز المتاح منهم في المدن الكبرى (IPEMED, 2012)؛ Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ (Brahamia, 2022)

• ضعف الخدمات الوقائية وغياب شبكة وطنية منظمة للرعاية الأولية (IPEMED, 2012)؛ Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ (Brahamia, 2022)

من زاوية اقتصاد الصحة، يعكس هذا الوضع حالة ندرة شديدة في الموارد الصحية، حيث كان الطلب الاجتماعي على الرعاية واسعاً بينما كان العرض الصحي محدوداً ومتركزاً جغرافياً. ولذلك لم تكن المشكلة في عدد الهياكل فقط، بل في قدرتها الفعلية على الوصول إلى السكان الأكثر حاجة.

سادساً: المبحث الثاني: النظام الصحي الموروث، طبيعته ونقاط ضعفه

كان النظام الصحي الموروث عن الاستعمار نظاماً انتقائياً وغير شامل. فقد تركزت المستشفيات والخدمات الأفضل في المدن الكبرى والمناطق التي كانت تخدم الإدارة الاستعمارية والمستوطنين، بينما ظلت مساحات واسعة من الريف والداخل والجنوب تعاني من نقص في المرافق الصحية والكوادر والتجهيزات (Brahamia, 2022)؛ (IPEMED, 2012)

- ضعف البنية التحتية الصحية وقدم التجهيزات وصعوبة صيانتها (Brahamia, 2022)؛ (IPEMED, 2012)
- غياب إدارة صحية وطنية موحدة قادرة على التخطيط وتوزيع الموارد.

• هيمنة منطق العلاج الاستشفائي على حساب الوقاية والرعاية الأولية (Brahamia, 2022)؛ (IPEMED, 2012)

• تفاوت جغرافي واضح في الوصول إلى الخدمات الصحية (Brahamia, 2022)؛ (IPEMED, 2012)

• الاعتماد المؤقت على المساعدات والتعاون الخارجي لسد النقص الحاد.

سابعاً: تركيب المحاضرة

توضح هذه المرحلة أن السياسة الصحية في الجزائر لم تبدأ من وضع طبيعي، بل من أزمة مركبة شملت المرض، نقص الموارد، ضعف التنظيم، وتفاوت الوصول إلى الخدمة. ومن هنا يمكن فهم السياسات اللاحقة مثل التوسع في التكوين، التعاون الدولي، ومجانية العلاج بوصفها استجابات تاريخية لمشكلات تأسيسية (IPEMED, 2012)؛

Brahamia, 2022)؛ Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007

ثامناً: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

نص الحالة: ولاية داخلية سنة 1963

تعيش عائلات كثيرة في منطقة داخلية بعيدة عن المدن الكبرى. ينتشر السل والأمراض المعوية بين الأطفال، ولا يوجد إلا مركز صحي صغير يفتقر إلى طبيب دائم. يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مستشفى، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وارتفاع الوفيات.

أسئلة الحالة التطبيقية:

السؤال الأول: ما المفاهيم التي تعكسها هذه الحالة من حيث الوضع الصحي عند الاستقلال؟

السؤال الثاني: كيف يبرز المثال ضعف النظام الصحي الموروث؟

السؤال الثالث: ما الإجراءات الأولية التي كان يمكن اعتمادها لتحسين الوصول إلى الرعاية؟

تاسعاً: الحل النموذجي المقترح

محور الإجابة	عناصر الإجابة النموذجية
تشخيص الوضع الصحي	تعكس الحالة انتشار الأمراض المعدية، ارتفاع الحاجة إلى الوقاية، ونقص الموارد البشرية الصحية، مع ارتباط المرض بالفقر وبعد المرافق الصحية.
ضعف النظام الموروث	تظهر الحالة أن النظام الموروث كان متركزاً في المدن وغير قادر على تغطية المناطق الداخلية، كما يفتقر إلى تنظيم فعال للرعاية الأولية.

إنشاء وحدات صحية جوارية ومتنقلة، إطلاق حملات تلقيح، تعيين ممرضين محليين، واستقدام أطباء مؤقتين مع بناء مسار تكوين وطني.	الإجراءات المقترحة
---	--------------------

المحاضرة الثانية: الحاجات الصحية التي أدت إلى إدخال مجانية الطب سنة 1974

تمهيد المحاضرة

تتناول هذه المحاضرة أحد أهم التحولات في تاريخ السياسة الصحية الجزائرية، وهو اعتماد مجانية العلاج سنة 1974. غير أن فهم هذا القرار يتطلب تجاوز النظرة القانونية أو السياسية المباشرة، والنظر إليه بوصفه استجابة لحاجات صحية واجتماعية واسعة تراكمت بعد الاستقلال، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للأسر، ونقص الممارسين، وغياب شبكة تكوين صحية قادرة على تلبية الطلب المتزايد.

تكمن أهمية هذه المحاضرة في أنها تبيّن الفرق بين الإعلان عن الحق في العلاج وبين القدرة الفعلية على استعمال هذا الحق. فالمجانية ترفع الحاجز المالي المباشر، لكنها لا تكفي وحدها إذا لم توجد مؤسسات قريبة، وأطباء وممرضون، وتنظيم يسمح باستقبال المرضى وتوجيههم. لذلك تصبح الموارد البشرية والتعاون الدولي وبناء التكوين الوطني عناصر مرافقة لا تقل أهمية عن القرار نفسه.

من الناحية البيداغوجية، تساعد هذه المحاضرة الطالب على تحليل المجانية كسياسة اجتماعية واقتصادية في آن واحد. فهي سياسة تعكس التضامن الوطني وتوسيع المواطنة الصحية، لكنها تطرح أيضاً سؤال الاستدامة، والقدرة التنظيمية، وحسن توزيع العرض الصحي. وبذلك تمهد لفهم التخطيط الصحي في الثمانينيات وتمويل الصحة في المراحل اللاحقة.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	التفصيل
المقياس	النظام الصحي الجزائري ونظام الحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب – السداسي الثاني
الموقع داخل البرنامج	الفصل 2: الحاجات الصحية التي أدت إلى إدخال مجانية الطب سنة 1974

الفكرة المركزية	تفسير مجانية العلاج باعتبارها استجابة سياسية واجتماعية لحاجات صحية واسعة، ونقص في الممارسين وهياكل التكوين.
-----------------	---

ثانياً: الأهداف التعليمية

- أن يشرح الطالب العلاقة بين ضعف التغطية الصحية وقرار مجانية العلاج.
- أن يحدد آثار نقص الممارسين الصحيين وغياب هياكل التكوين.
- أن يفسر دور التعاون الدولي في تغطية العجز الصحي بعد الاستقلال.
- أن يناقش مزايا ومحدوديات مجانية العلاج من زاوية اقتصاد الصحة.

ثالثاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
مجانية العلاج	سياسة تزيل العائق المالي المباشر أمام العلاج في القطاع العمومي.
نقص الممارسين الصحيين	نقص الأطباء والمرضى والقابلات والتقنيين الضروريين لتقديم الخدمة الصحية.
غياب هياكل التكوين	ضعف كليات الطب ومعاهد التكوين شبه الطبي وبرامج التخصص في المراحل الأولى.
التعاون الصحي الدولي	استقدام أطباء وخبرات من دول أخرى لسد العجز ونقل المعرفة.
التغطية الصحية	قدرة السكان على الاستفادة الفعلية من الخدمة الصحية دون حاجز مالي أو جغرافي.

رابعاً: مدخل تحليلي

يمثل قرار مجانية العلاج سنة 1974 محطة سياسية واجتماعية كبرى، لكنه لا يفهم بمعزل عن واقع العرض الصحي الضعيف الذي سبق القرار. فقد كان الطلب الاجتماعي على العلاج واسعاً، بينما كان عدد الممارسين وهياكل التكوين غير كافيين، وهو ما جعل المجانية في حاجة إلى سياسات مرافقة تتعلق بتكوين الأطباء، استقدام الكفاءات، وتوسيع المؤسسات الصحية.

تساعد هذه المحاضرة الطالب على التمييز بين الحق المعلن في العلاج والقدرة الفعلية على الاستفادة منه. فالمجانية تزيل العائق المالي المباشر، لكنها لا تعالج وحدها مشكلة غياب الطبيب أو بعد المرفق الصحي أو ضعف التنظيم. لذلك تبرز أهمية الربط بين العدالة الاجتماعية، الموارد البشرية، والتعاون الدولي في بناء السياسة الصحية.

جاءت مجانية العلاج سنة 1974 في سياق بناء الدولة الاجتماعية ومحاولة توسيع الحق في الصحة. غير أن هذا القرار لا يمكن فهمه فقط بوصفه إعلاناً قانونياً أو سياسياً، بل ينبغي ربطه بحاجات صحية حقيقية: نقص الأطباء، ضعف التكوين، اتساع الأمراض، الفقر، وصعوبة تحمل الأسر لتكاليف العلاج (IPEMED, 2012).؛ Brahamia, 2022؛ القانون 11-18، (2018)

خامساً: المبحث الأول: حاجات الممارسين وغياب هياكل التكوين

بعد الاستقلال، غادر عدد كبير من الأطباء الذين كانوا يعملون في النظام الصحي السابق، ولم تكن الجزائر تمتلك بعد قاعدة تكوين كافية لتعويض هذا النقص بسرعة. ولذلك ظهر عجز مزدوج: عجز عددي في الأطباء والمرضين، وعجز مؤسسي في الهياكل القادرة على تكوينهم محلياً (Brahamia, 2022).؛ (IPEMED, 2012)

- نقص الأطباء العاميين والأخصائيين، خاصة خارج المدن الكبرى (Brahamia, 2022).؛ (IPEMED, 2012)
- ضعف مدارس التكوين شبه الطبي وقلة التأطير الوطني (Brahamia, 2022).؛ (IPEMED, 2012)
- غياب برامج تخصص كافية لتغطية الحاجات المتنوعة للسكان (Brahamia, 2022).؛ (IPEMED, 2012)
- سوء توزيع الكوادر المتوفرة بين المدن والريف والجنوب (Brahamia, 2022).؛ (IPEMED, 2012)

اقتصادياً، يعني نقص الممارسين أن مجانية العلاج وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك عرض صحي قادر على استقبال المرضى. لذلك كان بناء الموارد البشرية شرطاً أساسياً لتحويل الحق في العلاج إلى خدمة فعلية.

سادساً: المبحث الثاني: التعاون الدولي لتوظيف الممارسين الصحيين

لمواجهة العجز الحاد، اعتمدت الجزائر على التعاون الدولي من خلال استقدام أطباء وممارسين من دول صديقة، وإرسال طلبة للتكوين، والاستفادة من الخبرات الخارجية. كان هذا التعاون حلاً انتقالياً ضرورياً، لكنه لم يكن بديلاً عن بناء منظومة تكوين وطنية مستدامة (IPEMED, 2012).؛ (Brahamia, 2022؛ القانون 11-18، (2018)

- سد النقص العاجل في الأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

- توجيه جزء من الكفاءات الأجنبية نحو المناطق المحرومة (IPEMED, 2012).؛ Brahamia, 2022؛ القانون 18-11، (2018)
- نقل الخبرة الطبية وتنظيم العمل الصحي إلى الكوادر الجزائرية (IPEMED, 2012).؛ Brahamia, 2022؛ القانون 18-11، (2018)
- تمهيد الطريق لتوسيع التكوين الوطني في الطب وشبه الطب.

سابعاً: تركيب المحاضرة

يمكن فهم مجانية العلاج سنة 1974 بوصفها نتيجة تفاعل بين حاجة اجتماعية واسعة إلى العلاج وحاجة مؤسساتية إلى بناء عرض صحي عمومي. فالتعاون الدولي دعم جانب العرض مؤقتاً، بينما عبرت المجانية عن خيار سياسي يهدف إلى ضمان الوصول إلى العلاج على أساس المواطنة والتضامن (IPEMED, 2012).؛ Brahamia, 2022؛ القانون 18-11، (2018)

ثامناً: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

نص الحالة: أسرة محدودة الدخل سنة 1974

أسرة ريفية لديها طفل مصاب بمرض معدٍ يحتاج إلى علاج سريع. قبل مجانية العلاج، كانت كلفة التنقل والكشف والدواء تمثل عبئاً كبيراً، مما يدفع الأسرة إلى تأجيل العلاج. بعد اعتماد المجانية، أصبح بإمكان الأسرة التوجه إلى مؤسسة صحية عمومية دون دفع مباشر عند تلقي الخدمة (Brahamia, 2022).؛ القانون 18-11، (2018)

أسئلة الحالة التطبيقية:

السؤال الأول: كيف تفسر هذه الحالة العلاقة بين الفقر والحاجة إلى مجانية العلاج؟

السؤال الثاني: لماذا لا تكفي مجانية العلاج وحدها دون توفر ممارسين صحيين؟

السؤال الثالث: ما دور التعاون الدولي في جعل سياسة المجانية أكثر قابلية للتطبيق؟

تاسعاً: الحل النموذجي المقترح

محور الإجابة	عناصر الإجابة النموذجية
العلاقة بين الفقر والمجانية	تظهر الحالة أن العائق المالي يؤدي إلى تأجيل العلاج وتفاقم المرض، وأن المجانية تقلل الإقصاء الصحي وتحمي الفئات الفقيرة.

إذا لم يتوفر أطباء وممرضون ومرافق قريبة، تبقى المجانية حقاً نظرياً؛ لذلك يحتاج الطلب المتزايد إلى عرض صحي منظم.	شروط فعالية المجانية
ساهم التعاون الدولي في توفير أطباء وخبرات بشكل عاجل، مما دعم المؤسسات العمومية وساعد على توسيع التغطية في المراحل الأولى.	دور التعاون الدولي

المحاضرة الثالثة: التطور المخطط لتوفير الرعاية الصحية العامة خلال الثمانينيات

تمهيد المحاضرة

تركز هذه المحاضرة على مرحلة الانتقال من توسيع الحق في العلاج إلى تنظيم العرض الصحي وتخطيطه. فبعد مجانية العلاج، أصبح الطلب على المؤسسات الصحية أكبر وأكثر انتظاماً، وهو ما فرض على الدولة التفكير في كيفية تقديم الرعاية بصورة قريبة ومنظمة، لا الاكتفاء ببناء مستشفيات مركزية بعيدة عن أغلب السكان.

تظهر أهمية الثمانينيات في كونها مرحلة أعطت مكانة أكبر للوقاية والرعاية الصحية الأولية. فالتلقيح، متابعة الأمومة والطفولة، الكشف المبكر، وقاعات العلاج الجوارية ليست خدمات ثانوية، بل أدوات أساسية لتقليل المرض قبل تعقده، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وخفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الأسر والنظام الصحي.

يساعد هذا الدرس الطالب على إدراك أن كفاءة النظام الصحي لا تقاس فقط بحجم الموارد، بل بطريقة توزيعها بين الوقاية والعلاج، وبين الرعاية القاعدية والرعاية المتخصصة. لذلك يشكل التخطيط الصحي في هذه المحاضرة جسراً بين سياسة مجانية العلاج من جهة، وبين تنظيم الهرم الصحي والحماية الاجتماعية من جهة أخرى.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	التفصيل
المقياس	النظام الصحي الجزائري ونظام الحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب – السداسي الثاني
الموقع داخل البرنامج	الفصل 3: التطور المخطط لتوفير الرعاية الصحية العامة خلال الثمانينيات

الفكرة المركزية	إبراز كيف انتقل النظام الصحي إلى تخطيط العرض العمومي عبر الوقاية وتوسيع مرافق الرعاية الأولية.
-----------------	--

ثانياً: الأهداف التعليمية

- أن يشرح الطالب معنى التخطيط الصحي العمومي في سياق الثمانينيات.
- أن يحلل أهمية تطوير الرعاية الوقائية في تحسين المؤشرات الصحية.
- أن يفسر دور توسيع مرافق الرعاية الأولية في تخفيف الضغط على المستشفيات.
- أن يستخدم مفهومي الكفاءة التخصيصية وتحليل التكلفة والفعالية في تفسير السياسات الوقائية.

ثالثاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
التخطيط الصحي	اختيار مسبق لأولويات صحية وتوزيع الموارد وفق أهداف وطنية.
الرعاية الصحية الأولية	خدمات قريبة من السكان تقدم الوقاية والكشف المبكر والمتابعة الأساسية.
الرعاية الوقائية	تدخلات تمنع المرض أو تكشفه مبكراً مثل التلقيح ومتابعة الأمومة والطفولة.
الكفاءة التخصيصية	توجيه الموارد إلى الاستخدامات التي تحقق أكبر منفعة صحية بأقل تكلفة ممكنة.
تحليل التكلفة والفعالية	مقارنة تكلفة تدخل صحي بنتائجه الصحية المحققة.

رابعاً: مدخل تحليلي

بعد اعتماد مجانية العلاج، ظهر تحدي جديد يتمثل في كيفية الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية دون تحويل كل الحالات إلى المستشفيات الكبرى. لذلك شكلت الثمانينيات مرحلة تخطيط للعرض الصحي، حيث أصبحت الوقاية والرعاية الأولية خيارين ضروريين لتقريب الخدمة وتقليل الكلفة وتحسين المؤشرات الصحية.

توضح هذه المحاضرة أن نجاح النظام الصحي لا يقاس فقط بحجم الإنفاق أو عدد الهياكل الثقيلة، بل بقدرته على منع المرض قبل حدوثه، وكشفه مبكراً، ومعالجة الحالات البسيطة في أقرب مستوى ممكن من المواطن. ومن هنا تظهر أهمية مفاهيم الكفاءة التخصيصية وتحليل التكلفة والفعالية في تقييم السياسات الصحية.

بعد إقرار مجانية العلاج، ارتفع الطلب على الخدمات الصحية. وكان على الدولة أن تتجنب حصر الاستجابة في بناء مستشفيات كبرى فقط، لأن ذلك مكلف ومحدود الأثر إذا بقي السكان بعيدين عن الخدمات الأساسية. لذلك تميزت الثمانينيات بتقوية الرعاية الأولية وتطوير الوقاية بوصفهما خيارين أكثر فعالية وعدالة (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPEMED, 2012؛ Brahamia, 2023).

خامساً: المبحث الأول: تطوير الرعاية الوقائية

ركزت السياسات الصحية في الثمانينيات على الوقاية من الأمراض المعدية وخفض وفيات الرضع والأمهات. وقد شملت هذه السياسات برامج التلقيح، متابعة النساء الحوامل، مراقبة نمو الأطفال، وتحسين الوعي الصحي. كان الهدف هو منع المرض قبل وقوعه بدلاً من انتظار تحوله إلى حالة استشفائية مكلفة (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPEMED, 2012؛ Brahamia, 2023).

• تعزيز برامج التلقيح الوطني ضد الأمراض المعدية (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPEMED, 2012).

• تطوير خدمات حماية الأمومة والطفولة (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPEMED, 2012).

• متابعة نمو الأطفال والتغذية والكشف المبكر عن الأمراض.

• توسيع حملات التوعية الصحية والنظافة والوقاية.

من منظور اقتصاد الصحة، تعد الوقاية من أكثر التدخلات فعالية من حيث التكلفة. فتكلفة اللقاح أو الفحص الدوري أقل بكثير من تكلفة الاستشفاء الطويل أو الإعاقة أو فقدان الإنتاجية. كما أن التلقيح يحقق منفعة جماعية عبر حماية المجتمع وتقليل انتقال العدوى (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPEMED, 2012).

سادساً: المبحث الثاني: توسيع مرافق الرعاية الصحية الأولية

تطلبت مجانية العلاج تقريب الخدمات من السكان. لذلك توسعت الدولة في قاعات العلاج والعيادات متعددة الخدمات ومؤسسات الرعاية القريبة من المواطن. سمحت هذه الشبكة بمعالجة الحالات البسيطة محلياً، وتوجيه الحالات الأكثر تعقيداً إلى مستويات أعلى عند الحاجة (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPEMED, 2012؛ Brahamia, 2023).

- تقريب الخدمة الصحية من القرى والبلديات والمناطق الداخلية (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPAMED, 2012؛ Brahamia, 2023).
- خفض تكاليف التنقل والانتظار على المرضى والأسر / (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPAMED, 2012؛ Brahamia, 2023).
- تقليل الضغط على المستشفيات الكبرى من خلال الفرز والتوجيه.
- تحقيق عدالة مكانية أفضل في الوصول إلى الخدمات الأساسية (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPAMED, 2012؛ Brahamia, 2023).

سابعاً: تركيب المحاضرة

أثبتت تجربة الثمانينيات أن النظام الصحي لا يقاس فقط بعدد المستشفيات، بل بقدرته على منع المرض، وكشفه مبكراً، وتقديم العلاج في أقرب مستوى ممكن من المريض. لذلك شكلت الوقاية والرعاية الأولية أساساً لتحسين المؤشرات الصحية وتحقيق الاستدامة المالية (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPAMED, 2012؛ Brahamia, 2023).

ثامناً: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

نص الحالة: برنامج تلقيح في بلدية ريفية

قررت السلطات الصحية تنظيم حملة تلقيح للأطفال في بلدية ريفية كانت تسجل حالات متكررة من الحصبة. تم فتح نقاط تلقيح في قاعات العلاج القريبة، ومتابعة الأطفال غير الملقحين عبر الممرضين المحليين. بعد سنة، انخفضت الحالات المسجلة وتراجعت الإحالات الاستشفائية / (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007؛ IPAMED, 2012؛ Brahamia, 2023).

أسئلة الحالة التطبيقية:

السؤال الأول: كيف تعكس هذه الحالة أهمية الرعاية الوقائية؟

السؤال الثاني: ما أثر تقريب الخدمة على التكاليف غير المباشرة للأسر؟

السؤال الثالث: كيف يمكن تفسير نجاح الحملة بمفهوم تحليل التكلفة والفعالية؟

تاسعاً: الحل النموذجي المقترح

محور الإجابة	عناصر الإجابة النموذجية
أهمية الوقاية	الحملة تمنع المرض قبل حدوثه وتخفض الإصابات والمضاعفات، كما تساهم في حماية المجتمع عبر تقليل انتقال العدوى.
خفض التكاليف غير المباشرة	نقاط التلقيح القريبة تخفض كلفة النقل، الوقت الضائع، والتغيب عن العمل، وتزيد احتمال استفادة الأطفال من الخدمة.
تحليل التكلفة والفعالية	تكلفة اللقاح والتنظيم أقل بكثير من تكلفة علاج الحصبة ومضاعفاتها في المستشفى، لذلك تحقق الحملة نتائج صحية كبيرة بتكلفة محدودة.

المحاضرة الرابعة: هيكل وتنظيم النظام الصحي الجزائري

تمهيد المحاضرة

تنتقل هذه المحاضرة من التاريخ والسياسات العامة إلى بنية النظام الصحي وطريقة اشتغاله. فوجود مؤسسات صحية متعددة لا يعني بالضرورة وجود نظام فعال، ما لم تكن هذه المؤسسات مرتبة ضمن مستويات واضحة، تبدأ من الرعاية الجوارية وتنتهي بالمؤسسات المتخصصة والجامعية، مع مسار إحالة يسمح بتوجيه المريض حسب حاجته الفعلية.

يسمح مفهوم الهرم الصحي بفهم لماذا لا ينبغي أن تعالج كل الحالات في المستوى نفسه. فالحالات البسيطة تحتاج إلى تكفل قريب وسريع ومنخفض التكلفة، بينما تتطلب الحالات المعقدة تجهيزات وخبرات أعلى. وعندما يختل هذا التدرج، تظهر مشكلات الازدحام، الهدر، طول الانتظار، وارتفاع كلفة العلاج على المؤسسات وصناديق التأمين الاجتماعي.

كما تبرز المحاضرة العلاقة الوثيقة بين الصحة والحماية الاجتماعية. فالتأمين الاجتماعي لا يمثل مجرد آلية إدارية لتعويض النفقات، بل أداة لتجميع المخاطر وتمويل الرعاية على أساس التضامن. ومن ثم فإن التنظيم الهرمي، مسار الإحالة، والدفع من قبل الغير عناصر مترابطة تهدف إلى تحسين الوصول إلى العلاج وحماية الاستدامة المالية.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	التفصيل
المقياس	النظام الصحي الجزائري ونظام الحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب – السداسي الثاني
الموقع داخل البرنامج	الفصل 4: هيكل وتنظيم النظام الصحي الجزائري
الفكرة المركزية	فهم التنظيم الهرمي للنظام الصحي وعلاقته بالتأمين الاجتماعي الشامل واستدامة التمويل.

ثانياً: الأهداف التعليمية

- أن يشرح الطالب مستويات الهرم الصحي الجزائري ووظيفة كل مستوى.
- أن يفسر أهمية مسار العلاج والإحالة في الاستخدام الرشيد للموارد.
- أن يربط بين الحماية الاجتماعية وتمويل الرعاية الصحية.
- أن يحلل أثر التأمين الاجتماعي والدفع من قبل الغير على الوصول إلى العلاج.

ثالثاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
الهرم الصحي	تنظيم متدرج يبدأ بالرعاية الأولية ثم الثانوية ثم الثالثية.
الإحالة الطبية	انتقال منظم للمريض من مستوى صحي إلى آخر حسب تعقيد الحالة.
التأمين الاجتماعي	تأمين يمول جزءاً من النفقات الصحية عبر الاشتراكات والتضامن بين المؤمنين.
الدفع من قبل الغير	آلية تسمح للمريض بعدم الدفع المباشر لكامل تكلفة الخدمة أو الدواء عند الاستفادة.
تجميع المخاطر	تجميع مساهمات الأفراد لتمويل علاج من يمرض منهم في وقت معين.

رابعاً: مدخل تحليلي

ينتقل هذا الدرس من التاريخ الصحي إلى منطق التنظيم المؤسسي. فالنظام الصحي لا يعمل بفعالية إذا تحرك المريض داخله بطريقة عشوائية، أو إذا استُعملت المستشفيات الجامعية لمعالجة حالات بسيطة كان يمكن التكفل بها في المستوى الجوّاري. لذلك يكتسب الهرم الصحي أهمية عملية في تنظيم التدفق بين مستويات الرعاية.

كما أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد إطار إداري منفصل عن الصحة، بل هي آلية لتقاسم مخاطر المرض وتمويل جزء من الرعاية. ومن ثم فإن احترام مسار العلاج لا يحسن جودة الخدمة فقط، بل يساهم أيضاً في حماية صناديق الضمان الاجتماعي من الهدر ويحافظ على استدامة التمويل.

يقوم التنظيم الصحي الفعال على توزيع الأدوار بين مستويات الرعاية. فليست كل حالة صحية بحاجة إلى مستشفى جامعي، ولا يمكن للمؤسسات القاعدية أن تعالج كل الحالات المعقدة. لذلك يرتبط حسن التنظيم الهرمي بالاستعمال الرشيد للموارد وباستدامة صناديق التأمين الاجتماعي). القانون 83-11، 1983، Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023)

خامساً: المبحث الأول: نظام صحي ذو شكل هرمي

يعتمد النظام الصحي الجزائري على منطق التدرج في الرعاية. تبدأ الخدمة غالباً من المؤسسات الجوّارية وقاعات العلاج والعيادات متعددة الخدمات، ثم تنتقل الحالات التي تحتاج إلى استشفاء أو تخصص إلى المؤسسات العمومية الاستشفائية، بينما تتكفل المراكز الاستشفائية الجامعية بالحالات المعقدة والتكوين والبحث. (Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018)

• الرعاية الأولية: الوقاية، الكشف المبكر، المتابعة الأساسية، التوجيه (Brahamia, 2022). Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018)

• الرعاية الثانوية: الاستشفاء العام، الجراحة العامة، التخصصات الأساسية (Brahamia, 2022). Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018)

• الرعاية الثالثة: الحالات المعقدة، التقنيات الثقيلة، التكوين والبحث العلمي (Brahamia, 2022). Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018)

• مسار الإحالة: أداة لتجنب الازدحام غير المبرر في القمة الجامعية.

اقتصادياً، يهدف الهرم الصحي إلى منع تبديد الموارد. فمعالجة الحالات البسيطة في المستوى القاعدي أقل تكلفة وأكثر قرباً من المريض، بينما يخصص المستوى الجامعي للحالات التي تستدعي تجهيزات وخبرات عالية.

سادساً: المبحث الثاني: تغطية شاملة للتأمين الاجتماعي

لا تتفصل الصحة عن الحماية الاجتماعية. فقد تطور النظام الجزائري في اتجاه تغطية واسعة تسمح بتمويل جزء معتبر من العلاج والدواء عبر صناديق التأمين، خاصة بالنسبة للأجراء وغير الأجراء. وتقوم هذه الآلية على التضامن وتجميع المخاطر، بما يقلل العبء المباشر على المرضى). القانون 83-11، 1983، ؛ Brahamia, 2022؛ (Brahamia, 2023)

• مساهمة الأجراء وأرباب العمل وغير الأجراء في تمويل التأمين.

• تغطية الدواء وبعض الخدمات الصحية عبر آليات الضمان الاجتماعي). القانون 83-11، 1983، ؛ Brahamia, 2022؛ (Brahamia, 2023)

• تقليل النفقات المباشرة من الجيب من خلال الدفع من قبل الغير). القانون 83-11، 1983، ؛ Brahamia, 2022؛ (Brahamia, 2023)

• ربط الاستدامة المالية بحسن استعمال مسار العلاج وتجنب الهدر (Brahamia, 2022). ؛ Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018)

سابعاً: تركيب المحاضرة

إن الهرم الصحي والتأمين الاجتماعي عنصران متكاملان: الأول ينظم تدفق المرضى ويخفض الهدر، والثاني يضمن تقاسم المخاطر المالية. وكلما احترم المريض مسار الرعاية، أمكن حماية الموارد المالية وتحسين جودة الخدمة). القانون 83-11، 1983، ؛ Brahamia, 2022؛ (Brahamia, 2023)

ثامناً: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

نص الحالة: مريض يتوجه مباشرة إلى مستشفى جامعي

يعاني مريض من آلام بسيطة في الظهر، لكنه يتوجه مباشرة إلى مستشفى جامعي بدلاً من العيادة الجوارية. يؤدي ذلك إلى ازدحام في مصلحة متخصصة، تأخير حالات أكثر تعقيداً، وارتفاع تكلفة التكفل بحالة كان يمكن علاجها في مستوى أدنى.

أسئلة الحالة التطبيقية:

السؤال الأول: ما الخلل التنظيمي الذي تكشفه هذه الحالة؟

السؤال الثاني: كيف يؤثر عدم احترام الهرم الصحي على صناديق الضمان الاجتماعي؟

السؤال الثالث: ما الحلول التنظيمية الممكنة لتحسين مسار العلاج؟

تاسعاً: الحل النموذجي المقترح

محور الإجابة	عناصر الإجابة النموذجية
الخلل التنظيمي	تكشف الحالة عن كسر مسار الرعاية والإحالة، واستعمال مستوى عالي التكلفة لحالة بسيطة يمكن علاجها في الرعاية الأولية.
الأثر المالي	يزيد ذلك تكلفة الوحدة العلاجية، يرفع الضغط على الموارد، ويؤدي إلى تمويل خدمات كان يمكن تقديمها بتكلفة أقل.
الحلول الممكنة	تعزيز دور طبيب الرعاية الأولية، تنظيم الإحالة، توعية المرضى، ورقمنة الملف الطبي لتتبع المسار العلاجي.

المحاضرة الخامسة: النظام الصحي العمومي منذ سنة 2007

تمهيد المحاضرة

تعالج هذه المحاضرة التحولات التي عرفها النظام الصحي العمومي منذ سنة 2007 ، وهي مرحلة لم تعد فيها التحديات الصحية مرتبطة أساساً بالأمراض المعدية وحدها، بل أصبحت أكثر ارتباطاً بالأمراض المزمنة، الشيخوخة النسبية، وتزايد الحاجة إلى متابعة طويلة ومتخصصة. ولهذا فإن السؤال المركزي لم يعد فقط كيف نوسع التغطية، بل كيف نكيف العرض الصحي مع حاجات جديدة أكثر تعقيداً واستمراراً.

يساعد مفهوم التحول الديموغرافي والوبائي على فهم هذا التغير. فارتفاع مأمول الحياة وتغير أنماط المرض يعنinan أن المريض قد يحتاج إلى رعاية ممتدة لسنوات، تشمل أدوية، فحوصاً دورية، تصويراً طبياً، ومتابعة متعددة التخصصات. وهذا يرفع كلفة الرعاية ويزيد الضغط على المؤسسات الصحية وعلى صناديق الضمان الاجتماعي.

توضح المحاضرة أيضاً أن اللامركزية الصحية أصبحت ضرورة وليست مجرد خيار تنظيمي. فتركيز التخصصات في المدن الكبرى يجعل سكان المناطق الداخلية والجنوبية يتحملون تكاليف تنقل وانتظار مرتفعة، وقد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج. لذلك تمهد هذه المحاضرة لموضوع الموارد البشرية الصحية وتوزيع الأخصائيين في المحاضرة الموالية.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	التفصيل
المقياس	النظام الصحي الجزائري ونظام الحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب – السداسي الثاني
الموقع داخل البرنامج	الفصل 5: النظام الصحي العمومي منذ سنة 2007
الفكرة المركزية	تحليل أثر التحول الديموغرافي والوبائي على الطلب الصحي، وبيان ضرورة اللامركزية وتوسيع الرعاية المتخصصة.

ثانياً: الأهداف التعليمية

- أن يشرح الطالب معنى التحول الديموغرافي والوبائي في الجزائر.
- أن يفسر أثر الأمراض المزمنة والشيخوخة على كلفة الرعاية الصحية.
- أن يحلل سبب نمو الطلب على الرعاية المتخصصة منذ 2007.
- أن يربط بين اللامركزية وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية وتحقيق الإنصاف الجغرافي.

ثالثاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
التحول الديموغرافي	تغير بنية السكان مع ارتفاع مأمول الحياة وتزايد وزن الفئات المسنة نسبياً.
التحول الوبائي	انتقال عبء المرض من الأمراض المعدية الحادة إلى الأمراض المزمنة وغير السارية.
الأمراض المزمنة	أمراض طويلة الأمد تتطلب متابعة وأدوية وفحوصات مستمرة مثل السكري والضغط والسرطان.
اللامركزية الصحية	إعادة توزيع الخدمات والاختصاصات نحو مستويات قريبة من السكان بدل تركيزها في المدن الكبرى فقط.
الرعاية المتخصصة	خدمات تحتاج إلى أطباء أخصائيين وتجهيزات وتقنيات أعلى من الرعاية العامة.

رابعاً: مدخل تحليلي

توضح مرحلة ما بعد 2007 أن نجاح السياسات الصحية السابقة في خفض بعض الأمراض والوفيات أدى إلى بروز حاجات صحية جديدة. فارتفاع العمر المتوقع وتزايد الأمراض المزمنة جعلاً النظام الصحي أمام طلب أكثر تخصصاً واستمراراً وكلفة، وهو ما فرض إعادة التفكير في توزيع الخدمات والتجهيزات على المستوى الترابي.

تساعد هذه المحاضرة الطالب على فهم أن التحول الوبائي ليس مجرد تغير في قائمة الأمراض، بل هو تغير في اقتصاد الرعاية الصحية. فالأمراض المزمنة تحتاج إلى متابعة طويلة، أدوية وفحوصات متكررة، وتخصصات متعددة، مما يجعل اللامركزية وتقريب الرعاية المتخصصة ضرورة تنظيمية ومالية في الوقت نفسه.

عرف النظام الصحي الجزائري منذ بداية الألفية الثالثة وضعاً جديداً. فقد أدت سياسات الوقاية وتحسن الظروف الصحية إلى انخفاض بعض الأمراض المعدية وارتفاع مأمول الحياة، لكن ذلك ترافق مع زيادة الأمراض المزمنة وطلب أكبر على الرعاية المتخصصة. لذلك أصبحت اللامركزية ضرورة تنظيمية واقتصادية (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 ; Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007).

خامساً: المبحث الأول: آثار التحول الديموغرافي والوبائي

يعني التحول الديموغرافي تغير بنية السكان نحو ارتفاع العمر المتوقع وبداية تزايد حاجات الفئات الأكبر سناً. أما التحول الوبائي فيعني تراجع الوزن النسبي للأمراض المعدية الحادة مقابل تزايد الأمراض المزمنة وغير السارية، مثل السكري، ارتفاع الضغط، أمراض القلب، السرطان، وأمراض الشيخوخة (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 ; Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007).

- تزايد الحاجة إلى المتابعة المستمرة بدل العلاج القصير فقط.
 - ارتفاع الطلب على الأدوية المزمنة والفحوصات الدورية والتحاليل والتصوير.
 - تزايد كلفة التكفل بسبب طول مدة المرض وتعقيد العلاج.
 - ضغط متزايد على صناديق الضمان الاجتماعي وميزانية الدولة.
- من زاوية اقتصاد الصحة، تتحول الكلفة من نفقات محدودة لعلاج حالات حادة إلى نفقات طويلة الأمد ومستمرة. وهذا يفرض تطوير سياسات وقائية وتنظيمية جديدة، لأن المرض المزمن لا يعالج بزيارة واحدة بل يحتاج إلى مسار رعاية كامل.

سادساً: المبحث الثاني: نمو الطلب على الرعاية المتخصصة واللامركزية الضرورية

مع تزايد الأمراض المزمنة، لم تعد الرعاية العامة وحدها كافية. فمرضى القلب والسرطان والفشل الكلوي والسكري المعقد يحتاجون إلى أطباء أخصائيين وتجهيزات متطورة ومسارات متابعة منظمة. أدى ذلك إلى ضغط كبير على المستشفيات الجامعية والمراكز الكبرى، مما جعل اللامركزية ضرورة (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021). Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007)

- تقريب التخصصات الأساسية من المواطنين عبر المؤسسات الاستشفائية الولائية والمحلية.
- تخفيف الضغط عن المراكز الاستشفائية الجامعية حتى تتفرغ للحالات الأكثر تعقيداً.
- خفض تكاليف التنقل والإقامة والانتظار على المرضى القادمين من الداخل والجنوب.

تحقيق إنصاف جغرافي أفضل في الوصول إلى الرعاية المتخصصة (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).

سابعاً: تركيب المحاضرة

تكشف مرحلة ما بعد 2007 أن نجاح النظام الصحي السابق في خفض بعض الأمراض والوفيات خلق تحديات جديدة: شيخوخة نسبية، أمراض مزمنة، وكلفة أعلى. لذلك لا بد من تنظيم الرعاية المتخصصة وتوزيعها جغرافياً، بدل تركيزها في المدن الكبرى فقط (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).

ثامناً: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

نص الحالة: مريض سكري في منطقة داخلية

مريض يعاني من السكري منذ عشر سنوات ويحتاج إلى متابعة دورية عند طبيب مختص في الغدد، وفحوصات للعين والكلى والقلب. في ولايته لا تتوفر كل هذه الخدمات بانتظام، فيضطر إلى التنقل إلى مدينة كبرى عدة مرات في السنة، مما يرفع كلفة العلاج ويؤخر المتابعة (Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA, 2007). Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)

أسئلة الحالة التطبيقية:

السؤال الأول: كيف تعكس هذه الحالة آثار التحول الوبائي؟

السؤال الثاني: لماذا تزيد الأمراض المزمنة الطلب على الرعاية المتخصصة؟

السؤال الثالث: كيف يمكن أن تساهم اللامركزية في تحسين وضعية هذا المريض؟

تاسعاً: الحل النموذجي المقترح

محور الإجابة	عناصر الإجابة النموذجية
آثار التحول الوبائي	الحالة تمثل انتقال عبء المرض نحو الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة دائمة لا علاجاً قصير المدى فقط.
نمو الطلب المتخصص	السكري يفرض متابعة متعددة التخصصات وتحاليل وفحوصاً مستمرة، مما يزيد الطلب على أطباء وتقنيات متخصصة.
دور اللامركزية	توفير تخصصات أساسية وفحوص دورية في المؤسسات الجهوية يخفض التنقل والانتظار، ويحسن الإنصاف والاستمرارية العلاجية.

المحاضرة السادسة: الموارد البشرية في قطاع الصحة: القضايا الرئيسية والتحديات

تمهيد المحاضرة

تضع هذه المحاضرة العنصر البشري في قلب تحليل النظام الصحي. فالهيكل الصحية، مهما كانت مجهزة، لا تتحول إلى خدمة فعلية إلا بوجود أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين قادرين على تشغيلها وتنسيقها. لذلك فإن الموارد البشرية ليست مجرد بند في التسيير الإداري، بل مورد استراتيجي يحدد جودة الرعاية، سرعة التكفل، واستمرارية المتابعة.

تزداد أهمية هذا الموضوع مع التحول الديموغرافي والوبائي، لأن الأمراض المزمنة والمعقدة تفرض طلباً متزايداً على أطباء أخصائيين وتخصصات دقيقة. لكن المشكلة لا تكمن في العدد الإجمالي فقط، بل في نوعية التخصصات المطلوبة ومكان وجودها. فقد تتوفر الكفاءات في المدن الكبرى، بينما تبقى مناطق أخرى تعاني من نقص أو غياب خدمات متخصصة.

كما تفتح المحاضرة نقاشاً مهماً حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص. فغياب التنسيق بينهما قد يؤدي إلى تكرار الفحوصات، تشتت مسار المريض، ارتفاع الإنفاق المباشر من الجيب، وضعف استمرارية العلاج. ولذلك يهدف الدرس إلى ربط تخطيط الموارد البشرية بالإنصاف الصحي، الحوكمة، وكفاءة الإنفاق.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	البيان
المقياس	النظام الصحي الجزائري والحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب – السداسي الثاني
الوحدة	UF2 – الرصيد – 6 المعامل 4
الموقع داخل البرنامج	الفصل 6: الموارد البشرية في قطاع الصحة: القضايا الرئيسية والتحديات
موضوع الفصل	الحاجة إلى الأطباء الأخصائيين، التوزيع الجغرافي غير المتوازن، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

ثانياً: الفكرة المركزية للمحاضرة

لا يكفي بناء الهياكل الصحية أو توفير التمويل والتجهيزات لتحسين أداء النظام الصحي؛ إذ يتوقف الأداء بدرجة حاسمة على تخطيط الموارد البشرية الصحية، تكوينها، توزيعها الجغرافي، تحفيزها، وضمان التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص. لذلك تنظر هذه المحاضرة إلى الموارد البشرية بوصفها مورداً استراتيجياً يحدد جودة الخدمة الصحية، وعدالة الوصول إليها، وكلفة العلاج بالنسبة للدولة والمريض معاً. (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022)

Brahamia, 2022)

ثالثاً: الأهداف التعليمية

- شرح مفهوم الموارد البشرية الصحية ودورها في أداء النظام الصحي الجزائري.
- التمييز بين النقص العددي في العاملين الصحيين والنقص النوعي المرتبط بالتخصصات الدقيقة.
- تحليل أثر التوزيع الجغرافي غير المتوازن للأطباء الأخصائيين على الإنصاف الصحي.
- تفسير مظاهر ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مسار علاج المريض.
- توضيح مفاهيم اقتصاد الصحة لفهم تكاليف التنقل، الانتظار، والإنفاق المباشر من الجيب.

رابعاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
الموارد البشرية الصحية	مجموع الأطباء، الممرضين، القابلات، التقنيين، الإداريين، وكل العاملين الذين يساهمون مباشرة أو غير مباشرة في إنتاج الخدمة الصحية.
الحاجة إلى الأطباء الأخصائيين	الحاجة إلى كفاءات طبية دقيقة نتيجة التحول الوبائي والديموغرافي وارتفاع عبء الأمراض المزمنة والمعقدة.
سوء التوزيع الجغرافي	اختلال تركز الأطباء والخدمات المتخصصة بين الشمال والجنوب، وبين المدن الكبرى والمناطق الداخلية.
التصحر الطبي	حالة نقص حاد ومستمر في الموارد البشرية أو الخدمات المتخصصة داخل إقليم معين.
الإنصاف الصحي	إتاحة الوصول إلى الرعاية وفق الحاجة الصحية لا وفق مكان الإقامة أو القدرة على الدفع.
الإنفاق المباشر من الجيب	النفقات التي يدفعها المريض أو أسرته مباشرة عند طلب الخدمة الصحية، مثل النقل، الفحوصات، أو العلاج في القطاع الخاص.
الهجرة الداخلية للكفاءات	انتقال الأطباء والكفاءات من القطاع العام إلى الخاص، أو من المناطق الأقل جاذبية إلى المدن الكبرى.
المسار العلاجي المنسق	تنظيم انتقال المريض بين مستويات الرعاية والقطاعين العام والخاص وفق إحالة واضحة وملف طبي موحد وتغطية مالية مضبوطة.

خامساً: مدخل تحليلي

تتناول هذه المحاضرة العنصر البشري بوصفه قلب النظام الصحي. فالمستشفى لا يقدم خدمة فعالة بمجرد وجود الجدران والتجهيزات، بل يحتاج إلى أطباء، ممرضين، تقنيين، إداريين، ومسارات عمل منسقة. لذلك فإن أزمة الموارد البشرية قد تظهر حتى في وجود هياكل وتمويل، إذا غابت التخصصات المطلوبة أو تركزت في مناطق محدودة.

كما أن توزيع الأطباء بين الجهات، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، يؤثران مباشرة في الإنصاف الصحي وفي كلفة العلاج على الأسر. ومن ثم ينبغي قراءة الموارد البشرية لا كمسألة إدارية فقط، بل كقضية حوكمة صحية واقتصادية تحدد الوصول والجودة والاستدامة.

عرف النظام الصحي الجزائري منذ الاستقلال توسعاً مهماً في تكوين الأطباء وبناء المؤسسات الصحية وتوسيع التغطية العمومية. غير أن التحول الوبائي والديموغرافي، وارتفاع الطلب على الرعاية المتخصصة، جعلاً الإشكال أكثر تعقيداً من مجرد زيادة عدد العاملين في القطاع الصحي. فالسؤال المركزي أصبح: هل تتوفر التخصصات المطلوبة فعلاً؟ وأين تتمركز؟ وهل يعمل القطاعان العام والخاص ضمن مسار علاجي متكامل؟ (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023)

من زاوية اقتصاد الصحة، الطبيب المتخصص مورد نادر ومكلف واستراتيجي. وعندما يتركز هذا المورد في المدن الكبرى، ترتفع الكلفة الفعلية للوصول إلى العلاج على سكان المناطق الداخلية والجنوبية، حتى عندما تكون الخدمة العمومية مجانية من حيث المبدأ. لذلك ترتبط الموارد البشرية الصحية مباشرة بمفاهيم الإنصاف، الكفاءة، جودة الرعاية، والتحكم في النفقات الصحية (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023)

سادساً: المبحث الأول: الحاجة إلى الأطباء الأخصائيين والتوزيع الجغرافي غير المتوازن

الفرع الأول: تطور الطلب على الرعاية المتخصصة

أدى التحول الوبائي والديموغرافي إلى ارتفاع الطلب على تخصصات دقيقة مثل أمراض القلب، الأورام، جراحة الأعصاب، التخدير والإنعاش، الأشعة والتصوير الطبي، أمراض الكلى، وطب الشيخوخة. ولم يعد الاعتماد على الطب العام وحده كافياً لمواجهة الحالات المزمنة والمعقدة التي تتطلب تشخيصاً متقدماً ومتابعة طويلة الأمد.

ينبغي التمييز هنا بين الوفرة العددية العامة للأطباء وبين كفاية التخصصات المطلوبة. فقد يرتفع العدد الإجمالي للأطباء، ومع ذلك يبقى النظام الصحي عاجزاً عن تلبية الطلب في تخصصات معينة أو في مناطق جغرافية محددة. وهذا ما يجعل التخطيط الصحي مطالباً بالانتقال من منطق العدد الإجمالي إلى منطق المزيج المهاري والتخصصي المناسب لحاجات السكان (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023)

الفرع الثاني: مظاهر سوء التوزيع الجغرافي

لا تتعلق المشكلة بعدد الأطباء الأخصائيين فقط، بل بآماكن تركزهم. فجزء معتبر من الخدمات المتخصصة يميل إلى التركز في الشمال والمدن الكبرى، ولا سيما المدن التي تضم مراكز استشفائية جامعية ومخابر ومراكز تصوير متقدمة. في المقابل، تواجه بعض مناطق الهضاب العليا والجنوب صعوبات في استقطاب الأخصائيين أو الاحتفاظ بهم، بسبب ضعف التجهيزات، بعد المسافة، ظروف العمل، السكن، وفرص التكوين المستمر.

؛(Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021
Brahamia, 2022)؛Brahamia, 2023)

هذا الاختلال يولد ما يسمى بسوء التوزيع الجغرافي للموارد البشرية الصحية، وقد يتحول في بعض الأقاليم إلى تصرح طبي عندما يصبح غياب التخصصات أو ندرتها عائقاً دائماً أمام الوصول إلى الرعاية. ولا يقتصر أثر ذلك على التأخر في العلاج، بل يمتد إلى رفع كلفة الوصول، إضعاف المتابعة، وتعميق الفوارق بين السكان .
؛(Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021
Brahamia, 2022)؛Brahamia, 2023)

الفرع الثالث: التحليل من زاوية اقتصاد الصحة والسياسات الصحية

يمس سوء التوزيع مبدأ الإنصاف الصحي، لأن فرصة العلاج لا تعود مرتبطة بالحاجة الطبية فقط، بل بمكان إقامة المريض وقدرته على تحمل تكاليف التنقل والإقامة والانتظار. فالمريض الذي يعيش في منطقة بعيدة قد يتحمل أعباء غير مباشرة تشمل النقل، المرافقة، التغيب عن العمل، وتكاليف الإقامة، حتى قبل دفع أي مقابل مباشر للخدمة الطبية، (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021
Brahamia, 2022؛2021؛ Brahamia, 2023)

وعندما تدفع قوائم الانتظار أو غياب التخصص إلى اللجوء للقطاع الخاص، قد يتحول العبء إلى إنفاق مباشر من الجيب. وفي بعض الحالات، تصبح هذه النفقات ثقيلة على ميزانية الأسرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفحوصات متكررة أو عمليات معقدة أو متابعة طويلة المدى. لذلك لا يمكن فصل مشكلة الموارد البشرية عن موضوع تمويل الصحة وحماية الأسر من النفقات الصحية المرهقة (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021
Brahamia, 2022؛Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2023)

الفرع الرابع: الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين وحدود فعاليتها

اعتمدت الجزائر آليات لتوجيه الأطباء الأخصائيين نحو المناطق التي تعاني من نقص، ومن بينها الخدمة المدنية. غير أن نجاح هذه السياسة لا يتوقف على التعيين الإداري وحده، بل على القدرة على استبقاء الطبيب في بيئة عمل مناسبة. فالاستبقاء يتطلب توفير التجهيزات، السكن، الأمن المهني، فرص التكوين، التحفيز، وإمكانية ممارسة التخصص بفعالية. ولهذا فإن الحل لا يكون بإرسال الطبيب فقط، بل ببناء شروط مهنية ومؤسسية تسمح له بأداء عمله والاستمرار فيه (Brahamia, 2023)؛. القانون 18-11، 2018، ؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)

سابعاً: المبحث الثاني: القطاع العام والخاص وضعف التنسيق في مسار الرعاية

الفرع الأول: القطاع العام: الدور المركزي والضغط المتزايد

يمثل القطاع العام العمود الفقري للنظام الصحي الجزائري. فهو يستقبل الحالات الاستعجالية والثقيلة، يقدم جزءاً كبيراً من الرعاية المتخصصة، ويشكل فضاءً أساسياً للتكوين الطبي والبحث والممارسة السريرية. غير أن هذا القطاع يواجه ضغطاً متزايداً ناتجاً عن الطلب المرتفع، قوائم الانتظار، تفاوت التجهيزات بين المؤسسات، ونقص بعض التخصصات في أقاليم معينة (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).

(Brahamia, 2022؛ Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2023)

تتعرض هذه الضغوط على جودة الخدمة ومدة الانتظار وعلى قدرة الأطباء والفرق الصحية على المتابعة الدقيقة للمرضى. كما قد تؤدي إلى إرهاق العاملين الصحيين وارتفاع مخاطر عدم الرضا المهني، وهو ما يؤثر بدوره في الاستبقاء والتحفيز (Brahamia, 2023).؛ القانون 18-11، 2018، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)

الفرع الثاني: القطاع الخاص: مساهمة مهمة لكنها غير متوازنة

شهد القطاع الخاص نمواً في العيادات الجراحية، التصوير الطبي، مخابر التحاليل، وطب الاختصاص. ويمكن لهذا القطاع أن يساهم في تخفيف الضغط عن القطاع العام، غير أنه يميل غالباً إلى التركز في المدن الكبرى وفي الخدمات ذات المردودية المالية الأعلى. لذلك قد يستفيد منه السكان القادرون على الدفع أو المقيمون قرب المراكز الحضرية أكثر من غيرهم (Brahamia, 2023).؛ القانون 18-11، 2018، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)

من زاوية الموارد البشرية، قد يجذب القطاع الخاص بعض الأخصائيين بفعل ظروف العمل أو الدخل أو التنظيم، مما يؤدي إلى هجرة داخلية للكفاءات من القطاع العام إلى الخاص، أو من المناطق الأقل جاذبية إلى المناطق الأكثر جاذبية. ويزداد أثر هذه الهجرة عندما لا توجد آليات تنظيمية وتعاقبية واضحة تضمن التكامل بدل التنافس غير المنسق (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).؛

(Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023)

الفرع الثالث: مظاهر ضعف التنسيق بين القطاعين

المشكلة ليست في وجود قطاع خاص في حد ذاته، بل في ضعف إدماجه ضمن مسار رعاية منظم. ففي كثير من الحالات قد يتحرك المريض بين القطاعين بطريقة مشتتة: فحوصات في مخبر خاص، تصوير في مركز خاص، متابعة أو جراحة في مستشفى عمومي، ثم عودة إلى عيادة خاصة، من دون ملف طبي موحد أو إحالة واضحة أو

تغطية مالية مضبوطة (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023).

ينتج عن هذا الوضع تكرار بعض الفحوصات، ضياع الوقت، ارتفاع التكاليف، تشتت مسؤولية المتابعة، وضعف استمرارية الرعاية. كما أن غياب تعاقدات فعالة بين الدولة والقطاع الخاص في بعض الخدمات المتخصصة قد يدفع المريض إلى تحمل نفقات مباشرة كان يمكن الحد منها لو وُجدت آليات إحالة وتعاقد وتغطية أكثر تنظيماً. (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ القانون 18-11، 2018؛ Brahamia, 2023).

ثامناً: تركيب المحاضرة

يمكن تلخيص العلاقة التحليلية كما يأتي: عندما يكون عدد الأطباء الأخصائيين غير كافٍ، أو عندما يتوزعون بطريقة غير عادلة، ومع ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، تظهر أربع نتائج مترابطة: صعوبة الوصول إلى الرعاية المتخصصة، ضغط متزايد على المستشفيات العمومية، توسع الإنفاق المباشر من الجيب، وتراجع الإنصاف الصحي (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023).

لذلك فإن إصلاح الموارد البشرية الصحية لا ينفصل عن إصلاح الحوكمة الصحية. فالأمر يتطلب تخطيطاً وطنياً للتخصصات وفق حاجات السكان، توزيعاً جغرافياً عادلاً، تحفيزات للاستبقاء، تحسين ظروف العمل، رقمنة الملف الطبي، وتعزيز التعاقد المنظم بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤية تجعل المريض محور المسار العلاجي. (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023).

تاسعاً: مداخل عملية لتحسين وضع الموارد البشرية الصحية

- إعداد خريطة وطنية للاحتياجات من الأطباء الأخصائيين حسب الأقاليم والتخصصات والأعباء المرضية.
- توجيه التكوين الطبي نحو التخصصات ذات العجز، مع ربط التخطيط الجامعي بحاجات النظام الصحي.
- تعزيز الحوافز المهنية والاجتماعية للمناطق التي تعاني من نقص، بما في ذلك السكن والتجهيزات وفرص التكوين (Brahamia, 2023)؛ القانون 18-11، 2018؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).

- تحسين ظروف العمل في القطاع العام للحد من الإرهاق المهني والهجرة الداخلية للكفاءات (Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitière, 2021)
- تطوير الطب عن بعد والاستشارات المتخصصة عن بعد لدعم المناطق النائية دون أن يكون ذلك بديلاً عن التغطية البشرية الفعلية.
- اعتماد ملف طبي رقمي موحد يسهل الإحالة والمتابعة ويقلل تكرار الفحوصات (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitière, 2021؛ Brahamia, 2022؛ Brahamia, 2023)
- تنظيم علاقة تعاقدية واضحة مع القطاع الخاص في بعض الخدمات المتخصصة، مع حماية المريض من الدفع المباشر المفرط (Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitière, 2021)
- تقوية نظام المعلومات الصحية حتى يصبح التخطيط قائماً على بيانات دقيقة لا على تقديرات عامة.

عاشراً: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

- نص الحالة: مريض من ولاية جنوبية يعاني من مشكلة قلبية معقدة. بسبب عدم توفر أخصائيين في جراحة القلب في مستشفى ولايته، اضطر إلى السفر إلى مستشفى جامعي في العاصمة. وبعد وصوله، واجه قائمة انتظار طويلة في القطاع العام، فتوجه إلى عيادة خاصة لإجراء العملية وتحمل تكاليف مرتفعة من ماله الخاص (Brahamia, 2023؛ القانون 18-11، 2018؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitière, 2021)
- أسئلة الحالة التطبيقية:

- ما المفهوم الذي تعكسه هذه الحالة من زاوية توزيع الأطباء الأخصائيين؟
- كيف تؤثر المسافة وقوائم الانتظار على الإنصاف الصحي؟
- ما مظاهر ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في هذه الحالة؟
- ما الحلول الممكنة لتقليل عبء الإنفاق المباشر من الجيب في مثل هذه الحالات؟

حادي عشر: الحل النموذجي المقترح

أولاً: تعكس الحالة مفهوم سوء التوزيع الجغرافي للأطباء الأخصائيين، وقد تصل في بعض المناطق إلى ما يسمى التصحر الطبي. فغياب جراحة القلب في الولاية الجنوبية دفع المريض إلى الانتقال نحو مستشفى جامعي في العاصمة، وهو ما يدل على تركيز التخصصات الدقيقة في المدن الكبرى والمراكز الاستشفائية الجامعية مقابل ضعف توفرها في المناطق الداخلية والجنوبية.

ثانياً: يؤثر هذا الوضع مباشرة في الإنصاف الصحي؛ لأن الحصول على الرعاية المتخصصة لا يصبح مرتبطاً بالحاجة الطبية وحدها، بل بمكان الإقامة والقدرة على تحمل تكاليف التنقل والإقامة والانتظار. لذلك يتحمل المريض وأسرته أعباء غير مباشرة، وقد يتأخر العلاج بسبب المسافة وقوائم الانتظار.

ثالثاً: تكشف الحالة كذلك ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص. فالقطاع العام يوفر الخدمة من حيث المبدأ لكنه يعاني الضغط وقوائم الانتظار، بينما يقدم القطاع الخاص خدمة أسرع لكنه مكلف. وعندما لا توجد إحالة منظمة أو ملف طبي موحد أو آلية تعاقد واضحة، ينتقل المريض بين القطاعين بطريقة مشتتة وغير مضمونة التمويل.

رابعاً: تؤدي هذه الازدواجية إلى تعقيد مسار العلاج عبر تكرار الفحوصات، ضياع الوقت، ارتفاع الإنفاق المباشر من الجيب، وتشتت مسؤولية المتابعة. ويقترح لتقليل هذه الآثار تحسين توزيع الأخصائيين، تعزيز الحوافز للمناطق الناقصة، تطوير الإحالة والملف الطبي الرقمي، وتنظيم تعاقدات واضحة بين الدولة والقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة مع حماية المريض من الدفع المباشر المفرط.

ثاني عشر: خلاصة المحاضرة

تؤكد هذه المحاضرة أن النظام الصحي لا يقوم على المباني والتجهيزات وحدها، بل على موارد بشرية مؤهلة وموزعة بعدالة وقادرة على العمل ضمن تنظيم مؤسسي منسق. وتظهر أهمية الأطباء الأخصائيين بوضوح في ظل التحول الوبائي والديموغرافي، لكن القيمة الحقيقية لهذه الموارد لا تتحقق إلا إذا وُضعت في المكان المناسب، بالتخصص المناسب، وبآليات إحالة وتنسيق تحمي المريض من التعقيد والتكاليف المفرطة. ويمهد هذا الفصل للانتقال إلى موضوع تمويل الصحة، لأن سوء توزيع الموارد البشرية وضعف التنسيق يؤديان في النهاية إلى رفع الكلفة على الدولة والأسرة معاً (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme .

Brahamia, 2023)؛ Brahamia, 2022؛ Hospitalière, 2021

المحاضرة السابعة: نفقات الصحة وآليات التمويل

تمهيد المحاضرة

تتناول هذه المحاضرة البعد المالي للنظام الصحي، وهو بعد أساسي لفهم قدرة الدولة والضمان الاجتماعي والأسر على تحمل تكاليف الرعاية. فكل خدمة صحية، حتى عندما تقدم مجاناً للمريض عند نقطة الاستعمال، لها تكلفة تتحملها ميزانية الدولة أو صناديق التأمين أو المريض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تكتسب نفقات الصحة أهمية متزايدة بسبب اتساع التغطية، تطور التقنيات الطبية، ارتفاع أسعار الأدوية، وزيادة الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة. لذلك لا يكفي أن نطرح سؤال: من يدفع؟ بل يجب أن نطرح أيضاً سؤال: كيف تمول الخدمات بطريقة عادلة ومستدامة، وكيف يمكن تقليل الهدر دون المساس بحق المريض في العلاج؟

من الناحية التعليمية، تهدف المحاضرة إلى مساعدة الطالب على فهم إصلاح الضمان الاجتماعي، مصادر تمويل الصحة، ومشكلة الإنفاق المباشر من الجيب. كما تربط بين التمويل والتنظيم، لأن سوء استعمال الهرم الصحي، ضعف الوقاية، وتشنت المسار العلاجي كلها عوامل تزيد الكلفة وتضعف الاستدامة المالية.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	البيان
المقياس	النظام الصحي الجزائري والحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب - السداسي الثاني
الوحدة	UF2 - الرصيد 6 - المعامل 4
الموقع داخل البرنامج	الفصل السابع: نفقات الصحة وآليات التمويل

موضوع الفصل	إصلاح الضمان الاجتماعي لسنة 1983؛ نمو نفقات الصحة؛ الإنفاق المباشر من الجيب؛ مخاطر اختلال التمويل والإنصاف.
-------------	---

ثانياً: الفكرة المركزية للمحاضرة

تمويل الصحة ليس مجرد مسألة محاسبية، بل هو آلية لتحديد من يدفع، وكيف تجمع الموارد، وكيف توزع على مقدمي الخدمات، وكيف تُحمى الأسر من النفقات الصحية الثقيلة. لذلك تركز هذه المحاضرة على العلاقة بين إصلاح الضمان الاجتماعي، تطور الإنفاق الصحي، وتزايد الإنفاق المباشر من الجيب، مع بيان أثر ذلك على الإنصاف والاستدامة المالية للنظام الصحي). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

ثالثاً: الأهداف التعليمية

- شرح معنى نفقات الصحة وآليات التمويل في اقتصاد الصحة.
- تفسير دور إصلاح الضمان الاجتماعي لسنة 1983 في تمويل النظام الصحي الجزائري.
- التمييز بين التمويل العمومي، تمويل الضمان الاجتماعي، والإنفاق المباشر من الجيب.
- تحليل أسباب نمو الإنفاق الصحي وعدم التحكم فيه.
- بيان أثر الإنفاق المباشر من الجيب على الإنصاف الصحي وحماية الأسر.
- تطبيق المفاهيم على حالة عملية تتعلق بمريض يتحمل تكاليف علاجية خارج التغطية الكافية.

رابعاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
نفقات الصحة	مجموع الموارد المالية التي تُنفق على الوقاية، العلاج، التشخيص، الأدوية، التسيير، التجهيز، والتكوين الصحي.

آليات التمويل	الطرق التي تُجمع بها الأموال وتُدفع بها تكاليف الخدمات الصحية: ميزانية الدولة، الضمان الاجتماعي، مساهمات الأسر، التأمينات، أو التعاقد.
التمويل العمومي	تمويل يعتمد على الميزانية العامة والجباية، ويهدف إلى ضمان خدمات صحية أساسية ذات طابع عمومي.
الضمان الاجتماعي	تمويل قائم على اشتراكات العمال وأصحاب العمل، ويُستخدم لتغطية جزء من تكاليف العلاج والأدوية والخدمات الصحية.
الإنفاق المباشر من الجيب	النفقات التي يدفعها المريض أو أسرته مباشرة عند طلب الخدمة، مثل كشف خاص، دواء غير معوض، تحاليل، تصوير، نقل، أو إقامة.
النفقات الصحية الكارثية	وضعية تصبح فيها النفقات الصحية مرتفعة إلى درجة تهدد استهلاك الأسرة أو تدفعها إلى الاستدانة أو التخلي عن العلاج.
الاستدامة المالية	قدرة النظام على تمويل خدمات صحية مقبولة الجودة دون عجز دائم أو نقل مفرط للعبء إلى المرضى.
الحماية المالية الصحية	قدرة الفئات ذات الدخل المحدود أو المقيمة في مناطق بعيدة على الحصول على العلاج دون عوائق مالية مفرطة.

خامساً: مدخل تحليلي

ينقل هذا الدرس إلى البعد المالي للنظام الصحي. فالخدمة الصحية لا تنتج فقط آثاراً طبية، بل تخلق أيضاً أعباء مالية تتحملها الدولة والضمان الاجتماعي والأسر. لذلك فإن فهم نفقات الصحة وآليات التمويل ضروري لفهم قدرة النظام على الاستمرار وحماية المواطن من الفقر الناتج عن المرض.

توضح المحاضرة أن المشكلة ليست في ارتفاع النفقات وحده، بل في طريقة توجيهها وضبطها وعدالة توزيعها. فقد تكون الزيادة في الإنفاق مبررة إذا حسنت النتائج الصحية، لكنها تصبح إشكالية إذا أدت إلى هدر أو نقل العبء إلى جيوب المرضى. ولهذا يرتبط التمويل الجيد بالوقاية، التعاقد، الرقمنة، وحسن تنظيم مسار الرعاية.

تطورت النظم الصحية الحديثة في ظل قاعدة أساسية مفادها أن المرض لا ينتج كلفة طبية فقط، بل ينتج كلفة اقتصادية واجتماعية أيضاً. فالمريض قد يدفع ثمن الكشف والدواء والتحليل والنقل، وقد يفقد أيام عمل أو يحتاج إلى مرافق، وقد تضطر الأسرة إلى إعادة ترتيب ميزانيتها. لذلك يدرس اقتصاد الصحة ليس فقط كمية الخدمات المقدمة، بل كذلك طريقة تمويلها وتوزيع أعبائها بين الدولة والضمان الاجتماعي والأسر). القانون 83-11، 1983؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022)

في الجزائر، يقوم تمويل الصحة على مزيج من الإنفاق العمومي، مساهمة الضمان الاجتماعي، ومساهمات مباشرة أو غير مباشرة من الأسر. غير أن توسع الطلب على العلاج، ارتفاع كلفة التكنولوجيا الطبية والأدوية، التحول الوبائي نحو الأمراض المزمنة، وضعف التنسيق بين مستويات الرعاية، كلها عوامل تجعل التحكم في الإنفاق الصحي تحدياً دائماً). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022)

سادساً: المبحث الأول: إصلاح الضمان الاجتماعي لسنة 1983 ودوره في تمويل الصحة

الفرع الأول: معنى الضمان الاجتماعي في تمويل الصحة

يقوم الضمان الاجتماعي على مبدأ التضامن بين المشتركين: فالأفراد لا يدفعون بالضرورة وفق حجم مرضهم الحالي، بل يساهمون عبر اشتراكات تُمكن النظام من تغطية جزء من المخاطر الصحية. وبذلك يختلف الضمان الاجتماعي عن الدفع المباشر، لأنه يوزع المخاطر بين الأصحاء والمرضى، وبين الأجيال، وبين فئات الدخل المختلفة). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022)

من الناحية الاقتصادية، يؤدي الضمان الاجتماعي وظيفة الحماية المالية، لأنه يخفف الصدمة المالية التي يمكن أن تتعرض لها الأسرة عند المرض. كما يسمح بتجميع الموارد بصورة أكثر انتظاماً من الاعتماد الحصري على الدفع الفردي عند الحاجة إلى العلاج). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2022)

الفرع الثاني: إصلاح سنة 1983: الانتقال نحو تنظيم أوسع للتغطية

يمثل إصلاح الضمان الاجتماعي لسنة 1983 محطة مهمة في تنظيم منظومة الحماية الاجتماعية في الجزائر . فقد ارتبط هذا الإصلاح بتوسيع التغطية وتدعيم دور مؤسسات الضمان الاجتماعي في تحمل جزء من تكاليف العلاج والأدوية والخدمات الصحية .ومن ثم أصبح تمويل الصحة لا يعتمد فقط على ميزانية الدولة، بل أيضاً على مساهمات اجتماعية تُوجه لتغطية المخاطر الصحية). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

تتمثل أهمية هذا الإصلاح في أنه عزز منطق التضامن الاجتماعي في مواجهة المرض، وسمح بتقليص العبء المباشر على عدد كبير من المؤمن لهم وذوي الحقوق .غير أن فعاليته العملية ترتبط دائماً بمدى اتساع التغطية، انتظام الاشتراكات، مستوى التعويض، وضبط العلاقة بين الصندوق، مقدمي الخدمات، والمستفيدين). القانون-83 11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

الفرع الثالث: حدود التمويل القائم على الضمان الاجتماعي

رغم أهمية الضمان الاجتماعي، فإنه لا يلغي كل أشكال الدفع المباشر من الجيب .فقد يدفع المريض مبالغ إضافية عندما تكون الخدمة غير مغطاة بالكامل، أو عندما يكون الدواء غير معوض، أو عندما يختار القطاع الخاص بسبب طول الانتظار أو ضعف توفر الخدمة في القطاع العام .كما أن توسع القطاع غير الرسمي أو ضعف التصريح الحقيقي بالأجور قد يؤثر في قاعدة الاشتراكات والموارد المتاحة). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

لذلك فإن الضمان الاجتماعي يحتاج إلى إدارة مالية دقيقة، تحديث في آليات التعويض، رقابة على الاستهلاك غير الضروري، وتنسيق مع السياسات الصحية العمومية حتى لا يتحول إلى ممول سلبي لفاتورة صحية متنامية دون قدرة على التوجيه والتحكم). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

سابعاً: المبحث الثاني: نمو نفقات الصحة وصعوبة التحكم فيها والإنفاق المباشر من الجيب

الفرع الأول: لماذا ترتفع نفقات الصحة؟

يرتفع الإنفاق الصحي عادة بسبب عدة عوامل متداخلة .أولها التحول الديموغرافي وارتفاع نسبة كبار السن، لأن الشيخوخة تزيد الحاجة إلى المتابعة والعلاج طويل الأمد .ثانيها التحول الوبائي نحو الأمراض المزمنة مثل

السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، السرطان وأمراض الكلى. ثالثاً ارتفاع كلفة التكنولوجيا الطبية، التصوير، التحاليل المتقدمة، الأدوية المبتكرة، والتجهيزات المتخصصة). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

كما تسهم عوامل تنظيمية في ارتفاع النفقات، مثل تكرار الفحوصات بسبب غياب ملف طبي موحد، ضعف التنسيق بين مستويات الرعاية، تفضيل العلاج الاستشفائي بدل الوقاية والرعاية الأولية، وغياب تقييم اقتصادي كافٍ لبعض القرارات المتعلقة بشراء التجهيزات أو اعتماد العلاجات الجديدة). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

الفرع الثاني: الإنفاق غير المتحكم فيه: من المشكلة المحاسبية إلى المشكلة الصحية

لا يكون ارتفاع الإنفاق الصحي مشكلة في حد ذاته إذا أدى إلى تحسين واضح في جودة الرعاية والنتائج الصحية. لكن المشكلة تظهر عندما ترتفع النفقات دون تحسن مناسب في المؤشرات الصحية أو دون توزيع عادل للفوائد بين المناطق والفئات الاجتماعية. وهنا يصبح الإنفاق غير المتحكم فيه مؤشراً على ضعف الحوكمة الصحية، لا مجرد رقم مالي مرتفع.

تظهر صعوبة التحكم في الإنفاق عندما لا تكون هناك أدوات كافية لتقييم تكلفة الخدمة، متابعة الاستهلاك الدوائي، تحليل قوائم الانتظار، مراقبة التعاقدات، وربط التمويل بالأداء والجودة. كما يؤدي ضعف الوقاية والرعاية الأولية إلى انتقال الحالات إلى مراحل متقدمة وأكثر كلفة، وهو ما يرفع فاتورة العلاج على الدولة والضمان الاجتماعي والأسر). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

الفرع الثالث: العلاقة بين التمويل وجودة الخدمة

التمويل الجيد لا يعني فقط زيادة الموارد، بل يعني أيضاً توجيهها نحو الأولويات الصحية. فالإنفاق على الوقاية والرعاية الأولية قد يقلل الحاجة إلى علاج مكلف لاحقاً. والإنفاق على الرقمنة والملف الطبي الموحد قد يحد من تكرار الفحوصات. والتمويل المشروط بالجودة قد يحفز المؤسسات الصحية على تحسين الأداء بدل الاكتفاء بتغطية النفقات التاريخية). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021 (Brahamia, 2022)

من هنا، فإن إصلاح تمويل الصحة ينبغي أن يجمع بين ثلاثة أهداف: تعبئة موارد كافية، توزيع عادل لهذه الموارد، واستخدام كفء لها. فإذا اختلف أحد هذه الأهداف، قد يصبح النظام إما غير مستدام مالياً، أو غير عادل اجتماعياً،

Ministère de la Santé, de la ؛ 1983، 83-11 القانون (أو ضعيف الجودة من الناحية الصحية).
Brahamia, 2022)؛Population et de la Réforme Hospitalière, 2021

الفرع الرابع: الإنفاق المباشر من الجيب وآثاره على الإنصاف الصحي

الفرع الخامس: مفهوم الإنفاق المباشر من الجيب

يقصد بالإنفاق المباشر من الجيب كل مبلغ يدفعه المريض أو أسرته مباشرة عند طلب الخدمة الصحية، سواء تعلق الأمر بكشف طبي، دواء، تحاليل، تصوير، عملية جراحية، نقل، إقامة، أو مرافقة. ويزداد هذا الإنفاق عندما تكون التغطية غير كافية أو عندما يضطر المريض إلى القطاع الخاص بسبب ندرة الخدمة أو طول الانتظار في القطاع العام (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).
Brahamia, 2022)

الفرع السادس: لماذا يمثل خطراً على الأسر؟

يمثل الإنفاق المباشر خطراً لأنه يرتبط بلحظة المرض، أي بلحظة يكون فيها الفرد ضعيف القدرة على الاختيار والتفاوض. وقد تضطر الأسرة إلى الاستدانة أو بيع ممتلكات أو تقليص نفقات أساسية كالغذاء والتعليم والنقل. لذلك لا يقاس أثره بالمبلغ وحده، بل بنسبته إلى دخل الأسرة وقدرتها على التحمل (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).
Brahamia, 2022)

كما أن هذا النوع من الإنفاق يضعف مبدأ الإنصاف، لأن القدرة على العلاج تصبح جزئياً مرتبطة بالقدرة على الدفع. فالأسرة الميسورة تستطيع تسريع العلاج في القطاع الخاص أو تحمل تكاليف السفر والتحاليل، بينما قد تواجه الأسرة الفقيرة العلاج أو تتخلى عن بعض الخدمات (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).
Brahamia, 2022)

الفرع السابع: كيف يمكن الحد من الإنفاق المباشر؟

يتطلب الحد من الإنفاق المباشر تحسين توفر الخدمات في القطاع العام، تقليص قوائم الانتظار، توسيع التغطية الفعلية لبعض الخدمات والأدوية الأساسية، تنظيم التعاقد مع القطاع الخاص عندما تكون الخدمة غير متاحة في القطاع العام، وتطوير آليات إحالة واضحة تمنع المريض من التنقل العشوائي بين المؤسسات (القانون 83-11، 1983؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).
Brahamia, 2022)

كما أن الاستثمار في الوقاية والرعاية الأولية، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، يعد من أهم وسائل خفض الإنفاق المباشر على المدى المتوسط. فكلما تم الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة، انخفضت احتمالات المضاعفات

المكلفة التي تدفع المريض إلى فحوصات وعمليات وعلاجات أكثر كلفة (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ Brahamia, 2022).

ثامناً: تركيب المحاضرة

يمكن تلخيص منطق المحاضرة في العلاقة التالية: عندما تتوسع الحاجات الصحية وترتفع كلفة التكنولوجيا والأدوية، يصبح تمويل الصحة أكثر ضغطاً. وإذا لم تكن آليات التمويل منظمة وعادلة وفعالة، ينتقل جزء متزايد من العبء إلى الأسر عبر الإنفاق المباشر من الجيب. وعندما يرتفع هذا الإنفاق، يتراجع الإنصاف الصحي لأن العلاج يصبح مرتبطاً جزئياً بالقدرة على الدفع). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ Brahamia, 2022).

لذلك فإن إصلاح تمويل الصحة لا يقتصر على زيادة الميزانية، بل يتطلب تحسين الحوكمة، ضبط مسارات العلاج، تقوية الضمان الاجتماعي، ربط التمويل بالجودة، الاستثمار في الوقاية، وتنظيم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يحمي المريض من تحمل أعباء مالية مفرطة). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ Brahamia, 2022).

تاسعاً: خلاصة المحاضرة

نفقات الصحة وآليات التمويل تمثل قلب اقتصاد الصحة، لأنها تحدد قدرة النظام الصحي على الاستمرار وعدالة توزيع أعبائه. وقد ساهم إصلاح الضمان الاجتماعي لسنة 1983 في تعزيز منطق التضامن والحماية من المخاطر الصحية، غير أن نمو الطلب على العلاج وارتفاع تكاليف التكنولوجيا والأدوية وضعف التنسيق يمكن أن يؤدي إلى إنفاق صحي غير متحكم فيه. وتظهر خطورة هذا الوضع عندما يتحول جزء معتبر من العبء إلى الأسر عبر الإنفاق المباشر من الجيب، بما يهدد الإنصاف الصحي والحماية المالية). القانون 83-11، 1983، Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)؛ Brahamia, 2022).

عاشراً: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

مريض يعاني من مرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة، تحاليل دورية، تصوير طبي، وأدوية شهرية. في ولايته تتوفر بعض الخدمات الأساسية في القطاع العام، لكن مواعيد التصوير متباعدة، وبعض الأدوية غير متوفرة بانتظام. لذلك يلجأ أحياناً إلى مركز تصوير خاص، ويشترى بعض الأدوية من ماله الخاص، كما يتحمل تكاليف النقل والمتابعة. ورغم أنه مؤمن اجتماعياً، فإن أسرته تشعر بأن المرض أصبح عبئاً دائماً على ميزانيتها). القانون

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 1983،83-11

Brahamia, 2022)؛2021

أسئلة الحالة التطبيقية:

- ما مصادر تمويل العلاج في هذه الحالة؟ وما الفرق بين التمويل العمومي، الضمان الاجتماعي، والإنفاق المباشر من الجيب؟
- كيف تعكس هذه الحالة مشكلة نمو نفقات الصحة وصعوبة التحكم فيها؟
- ما أثر الإنفاق المباشر من الجيب على الإنصاف الصحي والحماية المالية للأسرة؟
- اقترح إجراءات عملية يمكن أن تحد من العبء المالي على المريض دون الإضرار بجودة الخدمة.

حادي عشر: الحل النموذجي المقترح

السؤال	الإجابة النموذجية المقترحة
مصادر تمويل العلاج	تُظهر الحالة تداخلاً بين ثلاثة مصادر تمويل. التمويل العمومي يظهر في الخدمات الأساسية التي توفرها المؤسسات الصحية العامة. الضمان الاجتماعي يتدخل من خلال التعويض الجزئي أو الكلي لبعض الأدوية والفحوصات حسب القواعد المعمول بها. أما الإنفاق المباشر من الجيب فيظهر عندما يضطر المريض إلى دفع ثمن التحاليل، التصوير، الأدوية غير المتوفرة، التنقل، أو خدمات القطاع الخاص مباشرة من ميزانية الأسرة. الفرق الجوهري أن التمويل العمومي يقوم على الميزانية العامة، والضمان الاجتماعي يقوم على الاشتراكات والتعويض، بينما الإنفاق من الجيب يتحمله المريض عند لحظة المرض.
نمو نفقات الصحة	تعكس الحالة ارتفاع نفقات الصحة لأن المرض المزمن لا يحتاج إلى علاج عابر، بل إلى متابعة طويلة، أدوية

شهرية، فحوصات دورية، تصوير طبي، واستشارات متكررة. كما أن عدم توفر بعض الأدوية أو طول آجال المواعيد في القطاع العام يدفع المريض إلى القطاع الخاص، فتتقل الكلفة من النظام الصحي إلى الأسرة. وتزداد صعوبة التحكم في النفقات بسبب تطور التكنولوجيا الطبية، ارتفاع أسعار الأدوية، التحول الوبائي نحو الأمراض المزمنة، وتشتت مسار العلاج بين القطاعين العام والخاص.	
يؤثر الإنفاق المباشر من الجيب سلباً في الإنصاف الصحي والحماية المالية، لأنه يجعل القدرة على الحصول على العلاج مرتبطة جزئياً بمستوى دخل الأسرة ومكان إقامة المريض. الأسرة ذات الدخل المرتفع تستطيع شراء الأدوية، تسريع الفحوصات في القطاع الخاص، وتحمل تكاليف النقل، بينما قد توجل الأسرة الضعيفة العلاج أو تقلص نفقات أساسية أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى نفقات صحية كارثية إذا استهلك المريض جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، وهو ما يضعف مبدأ التضامن الذي يفترض أن تقوم عليه آليات تمويل الصحة.	أثر الإنفاق من الجيب
يمكن تخفيف العبء المالي على المريض عبر تحسين توفر الأدوية الأساسية في القطاع العام، تقليص آجال مواعيد التصوير والتحليل، تعزيز الرعاية الأولية والمتابعة المنتظمة للأمراض المزمنة، توسيع التعويض الفعلي لبعض الفحوصات الضرورية، وتنظيم التعاقد مع القطاع الخاص عندما تكون الخدمة غير متاحة في	الإجراءات العملية المقترحة

القطاع العام. كما ينبغي تطوير الملف الطبي الموحد لتجنب تكرار الفحوصات، وتوجيه التمويل نحو الوقاية والكشف المبكر، لأن ذلك يخفض المضاعفات المكلفة ويحافظ في الوقت نفسه على جودة الخدمة.	
--	--

المحاضرة الثامنة: رؤية 2030 لتطوير قطاع الصحة في الجزائر: النظام الصحي المتوقع وتكيف عرض الرعاية مع الشيخوخة وعبء الأمراض

تمهيد المحاضرة

تختتم هذه المحاضرة المطبوعة بفتح أفق استشرافي حول النظام الصحي الجزائري في أفق 2030. فالغاية ليست التنبؤ بالمستقبل بصورة مجردة، بل فهم نوع الإصلاحات التي يحتاجها القطاع حتى يصبح أكثر قدرة على مواجهة الشيخوخة النسبية، عبء الأمراض المزمنة، ارتفاع الطلب على الرعاية المتخصصة، وتزايد توقعات المواطنين تجاه الجودة والإنصاف.

تدفع رؤية 2030 الطالب إلى الربط بين كل المحاضرات السابقة: الوضع التاريخي، مجانية العلاج، التخطيط، الهرم الصحي، اللامركزية، الموارد البشرية، والتمويل. فالمستقبل الصحي لا يبنى بقرار واحد، بل بتكامل هذه العناصر ضمن سياسة عمومية قادرة على تحويل الموارد المتاحة إلى خدمات فعالة وقريبة ومستدامة.

تركز المحاضرة على فكرة التكيف المستمر لعرض الرعاية. فالنظام الصحي المنتظر ينبغي أن يكون أكثر وقائية، أكثر رقمية، أكثر تنسيقاً بين المستويات والقطاعات، وأكثر حساسية للفوارق الجغرافية والاجتماعية. ومن ثم تمثل هذه المحاضرة خلاصة تحليلية للمقياس ومدخلاً للتفكير في إصلاح صحي طويل الأمد.

أولاً: بطاقة المحاضرة وموقعها داخل البرنامج

العنصر	المحتوى
المقياس	النظام الصحي الجزائري والحماية الاجتماعية (AHSSP)
المستوى	السنة الأولى طب – السداسي الثاني

الموقع داخل البرنامج	الفصل الثامن: رؤية 2030 لتطوير قطاع الصحة في الجزائر
الفكرة المركزية	تتناول المحاضرة مطلبين فقط كما وردا في البرنامج : ملامح النظام الصحي المتوقع في أفق 2030 ، ثم كيفية تكييف عرض الرعاية الصحية مع آثار الشيخوخة وعبء الأمراض المستحثة أو المرتبطة بهذه التحولات.

ثانياً: تمهيد منهجي

تختم هذه المحاضرة المسار العام للمطبوعة بطرح سؤال استراتيجي حول مستقبل النظام الصحي الجزائري. فبعد دراسة التاريخ، التنظيم، الموارد البشرية والتمويل، يصبح المطلوب هو التفكير في النظام الصحي الذي يمكنه مواجهة حاجات 2030: شيخوخة السكان، الأمراض المزمنة، الرقمنة، جودة الرعاية، وتزايد الطلب على الإنصاف. لا تقدم رؤية 2030 جواباً تقنياً بسيطاً، بل إطاراً لتجميع الإصلاحات في مسار واحد. فالمستقبل الصحي لا يتعلق فقط بزيادة العرض، بل بتحويل طريقة عمل النظام: من رد الفعل إلى التوقع، ومن العلاج المتأخر إلى الوقاية والكشف المبكر، ومن المؤسسات المعزولة إلى مسار علاجي متكامل يضع المريض في المركز.

بعد دراسة تطور النظام الصحي الجزائري، تنظيمه، موارده البشرية، ونفقات الصحة وآليات التمويل، تنتقل هذه المحاضرة إلى سؤال استراتيجي: أي نظام صحي تحتاجه الجزائر في أفق 2030؟ (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، 2018)

لا يتعلق الأمر بمجرد زيادة عدد المستشفيات أو الأجهزة الطبية، بل ببناء قدرة مستدامة على الاستجابة لتحولات عميقة: شيخوخة السكان، انتشار الأمراض المزمنة، تزايد الطلب على الرعاية المتخصصة، الحاجة إلى رقمنة الخدمات، وضمان الإنصاف بين الجهات والفئات الاجتماعية (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Brahamia, 2023؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)

لذلك تُبنى المحاضرة على مطلبين فقط: المطلب الأول يوضح خصائص النظام الصحي المتوقع في أفق 2030، والمطلب الثاني يشرح كيفية تكييف عرض الرعاية الصحية مع آثار الشيخوخة وعبء الأمراض، بما في ذلك الأمراض والمضاعفات المستحثة عن التحولات الديموغرافية والوبائية. (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، 2018)

ثالثاً: الأهداف التعليمية

- أن يشرح الطالب معنى التخطيط الاستراتيجي الصحي في أفق 2030.
- أن يحدد ملامح النظام الصحي المتوقع: الإنصاف، الجودة، الاستدامة، الرقمنة، والحوكمة.
- أن يحلل أثر الشيخوخة والتحول الوبائي على الطلب على الخدمات الصحية.
- أن يفسر معنى تكيف عرض الرعاية مع عبء الأمراض المزمنة والمستحثة عن التحولات السكانية والصحية.
- أن يربط بين رؤية 2030 وقضايا التمويل والموارد البشرية وتوزيع الخدمات الصحية.
- أن يطبق المفاهيم السابقة على حالة عملية مرتبطة بالأمراض المزمنة والرعاية طويلة الأمد.

رابعاً: المفاهيم المفتاحية

المفهوم	المعنى المختصر
التخطيط الاستراتيجي الصحي	اتجاه طويل المدى لتحديد أولويات قطاع الصحة وموارده وإصلاحاته وفق حاجات السكان المستقبلية.
رؤية 2030 الصحية	تصور إصلاحي يهدف إلى جعل النظام الصحي أكثر قدرة على الوقاية، الإنصاف، الجودة، الرقمنة، والاستدامة.
الشيخوخة السكانية	ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع، بما يزيد الطلب على الرعاية المزمنة والتأهيلية وطويلة الأمد.
التحول الوبائي	انتقال عبء المرض من الأمراض المعدية أساساً إلى الأمراض المزمنة وغير السارية مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.
الأمراض المستحثة أو المرتبطة بالتحول الصحي	أمراض أو مضاعفات تتزايد نتيجة تغير نمط الحياة، الشيخوخة، عوامل الخطر، وتراكم الأمراض المزمنة.
الاستدامة المالية	قدرة النظام الصحي على الاستمرار في تمويل الخدمات وتحسينها دون تحميل الأسر أعباء مباشرة مفرطة.
المسار العلاجي المتكامل	ربط مستويات الرعاية والمؤسسات والمهنيين عبر إحالة واضحة وملف طبي ومتابعة مستمرة.

خامساً: مدخل تحليلي

تواجه النظم الصحية المعاصرة تحدياً مزدوجاً: من جهة، يزداد الطلب على خدمات صحية أكثر تخصصاً وتعقيداً؛ ومن جهة أخرى، تصبح الموارد المالية والبشرية محدودة مقارنة بحجم الحاجات. في الجزائر، يظهر هذا التحدي بوضوح مع اتساع الطلب على علاج الأمراض المزمنة، وارتفاع الحاجة إلى المتابعة طويلة الأمد، وتزايد الضغط على المستشفيات العمومية (Korea Development Institute & MOSF, 2013). (Brahamia, 2023؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)

تسمح رؤية 2030 بإعادة التفكير في النظام الصحي باعتباره نظاماً متكاملًا لا يقتصر على العلاج داخل المستشفى. فالصحة في أفق 2030 تتطلب رعاية أولية قوية، وقاية فعالة، توزيعاً عادلاً للموارد، رقمنة للمعلومات، تنسيقاً بين القطاعين العام والخاص، وتمويلاً أكثر قابلية للاستدامة. (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، 2018)

ومن زاوية اقتصاد الصحة، فإن أي إصلاح مستقبلي يجب أن يوازن بين ثلاثة أهداف: تحسين الوصول إلى الخدمات، التحكم في التكاليف، ورفع جودة الرعاية. وإذا اختلف أحد هذه الأبعاد، يصبح النظام معرضاً إما لعدم الإنصاف، أو لتضخم النفقات، أو لتراجع الثقة في الخدمة الصحية.

سادساً: المبحث الأول: ما النظام الصحي المتوقع في أفق 2030؟

الفرع الأول: نظام صحي أكثر إنصافاً في الوصول إلى الرعاية

يتطلب أفق 2030 تقليص الفوارق بين الشمال والجنوب، وبين المدن الكبرى والمناطق الداخلية، وبين الفئات القادرة على الدفع والفئات الهشة. فالإنصاف لا يعني فقط مجانية الخدمة في النصوص، بل يعني القدرة الفعلية على الوصول إلى الطبيب، الدواء، التحاليل، التصوير الطبي، والاستشفاء في وقت مناسب وبجودة مقبولة. لذلك ترتبط رؤية 2030 بتقوية الرعاية الجوارية، تحسين الإحالة بين المستويات، وتوجيه الموارد البشرية والتجهيزات نحو المناطق التي تعاني عجزاً واضحاً. (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، 2018)

الفرع الثاني: نظام صحي قائم على الوقاية والرعاية الأولية

كلما تأخر تشخيص المرض المزمن ارتفعت تكلفة علاجه. لذلك يفترض أن ينتقل النظام الصحي من منطق الانتظار داخل المستشفى إلى منطق الوقاية والكشف المبكر والمتابعة الدورية. ويشمل ذلك تعزيز طب الأسرة، متابعة السكري وارتفاع الضغط، حملات الكشف المبكر عن السرطان، وبرامج التنقيف الصحي.

الفرع الثالث: نظام صحي رقمي ومندمج

تسمح الرقمنة بتقليل تكرار الفحوصات، تحسين الإحالة، تقليل ضياع المعلومات، ومتابعة المريض عبر مسار علاجي واضح. ولا تكون الرقمنة فعالة إذا اقتصر على شراء برمجيات، بل يجب أن ترتبط بتكوين المستخدمين، حماية المعطيات، توحيد المعايير، وربط المؤسسات الصحية بشبكات معلوماتية قابلة للتشغيل البيني (Korea Development Institute & MOSF, 2013).

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، (2018)

la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، (2018)

الفرع الرابع: نظام صحي قابل للاستدامة مالياً

مع ارتفاع الأمراض المزمنة وتقدم السكان في السن، تزداد نفقات الأدوية والفحوصات والاستشفاء. لذلك تصبح الاستدامة المالية شرطاً أساسياً لرؤية 2030. والمقصود بها تنظيم النفقات وترشيدها دون التضحية بحقوق المريض في العلاج، وذلك عبر الوقاية، تقييم التكنولوجيا الصحية، تحسين الشراء العمومي، وتطوير آليات تعاقد وضبط أكثر فعالية. (Korea Development Institute & MOSF, 2013)؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، (2018)

Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، (2018)

الفرع الخامس: نظام صحي أكثر جودة وحوكمة

لا تكتمل رؤية 2030 بمجرد توسيع العرض الصحي، بل يجب أن ترتبط بقياس جودة الخدمات، تقليل آجال الانتظار، تحسين استقبال المرضى، استعمال البيانات في القرار، وتقييم أداء المؤسسات الصحية على أساس النتائج وليس على أساس حجم الإنفاق أو عدد الهياكل فقط. (Korea Development Institute & MOSF, 2013)؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 18-11، (2018)

القانون 18-11، (2018)

سابعاً: المبحث الثاني: تكييف عرض الرعاية الصحية مع آثار الشيخوخة وعبء الأمراض المستحثة

الفرع الأول: الشيخوخة وتغير طبيعة الطلب الصحي

تؤدي الشيخوخة إلى زيادة الطلب على خدمات المتابعة، الأدوية طويلة الأمد، إعادة التأهيل، العناية المنزلية، طب الشيخوخة، والرعاية التلطيفية. فالمرضى عند كبار السن لا يكون غالباً حالة معزولة، بل قد يتداخل فيه السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، هشاشة العظام، ومشكلات الحركة أو الذاكرة. هذا الوضع يجعل الرعاية الصحية أكثر تعقيداً لأنها تتطلب تنسيقاً بين الطبيب العام، الأخصائي، الصيدلي، الممرض، الأسرة، ومؤسسات الضمان الاجتماعي (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2023).

الفرع الثاني: عبء الأمراض المزمنة وغير السارية

تمثل الأمراض المزمنة تحدياً اقتصادياً وصحياً لأنها لا تُعالج غالباً بزيارة واحدة، بل تحتاج إلى متابعة مستمرة وفحوص دورية وتغيير في نمط الحياة. وإذا لم تُدار هذه الأمراض بشكل مبكر ومنظم، فإنها تؤدي إلى مضاعفات مكلفة مثل الفشل الكلوي، الجلطات، بتر الأطراف، والعجز الوظيفي (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ Brahamia, 2023).

الفرع الثالث: الأمراض والمضاعفات المستحثة عن التحولات الصحية

المقصود هنا أن بعض الأعباء المرضية لا تظهر بمعزل عن السياق الاجتماعي والديموغرافي، بل تُستحث أو تتفاقم بفعل الشيخوخة، أنماط الغذاء، قلة النشاط البدني، التدخين، التمدن، التلوث، والضغط النفسي. لذلك يجب ألا يكتفي النظام الصحي بعلاج النتيجة النهائية للمرض، بل يجب أن يتدخل على عوامل الخطر قبل تحولها إلى أمراض مزمنة ومضاعفات مكلفة (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Brahamia, 2023؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).

الفرع الرابع: من المستشفى إلى شبكة رعاية متكاملة

لا يمكن مواجهة الشيخوخة والأمراض المزمنة بالاعتماد المفرط على المستشفى وحده. فالمستشفى ضروري للحالات المعقدة، لكنه ليس المكان المناسب لكل مراحل المرض. لذلك يجب توجيه جزء مهم من الرعاية نحو المراكز الجوارية، المتابعة الخارجية، الرعاية المنزلية، والوقاية المجتمعية (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Brahamia, 2023؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021).

الفرع الخامس: الموارد البشرية المطلوبة للتكيف

يحتاج تكيف العرض الصحي إلى موارد بشرية متعددة التخصصات: أطباء عامون مكونون في المتابعة المزمدة، أطباء أخصائيون حسب الحاجات الوبائية، ممرضون في الرعاية المنزلية، مختصون في الصحة العمومية، تقنيو معلومات صحية، ومسيرو مؤسسات صحية قادرون على استعمال البيانات في القرار.

الفرع السادس: أدوات عملية لتكيف عرض الرعاية

يتطلب التكيف العملي تقوية الرعاية الأولية، إنشاء مسارات إحالة واضحة، اعتماد ملف طبي رقمي، تطوير برامج الكشف المبكر، توسيع خدمات الرعاية المنزلية، تنظيم التعاقد مع القطاع الخاص عند الحاجة، وترشيد الإنفاق بما يقلل الأعباء المباشرة على الأسر.

ثامناً: جدول تركيبي لأدوات التكيف

الأداة	آلية التطبيق
تقوية الرعاية الأولية	توسيع الوقاية والكشف المبكر، وتحويل الرعاية الأولية إلى مدخل منظم لمسار علاج المريض.
تحسين التوزيع الجغرافي	توجيه الأطباء والتجهيزات نحو المناطق التي تعاني نقصاً، مع توفير الحوافز وشروط العمل.
رقمنة النظام الصحي	إدماج الملف الطبي الرقمي، الإحالة الإلكترونية، وأنظمة متابعة الأمراض المزمنة.
ضبط النفقات الصحية	الحد من الإنفاق غير الضروري، تقييم التكنولوجيا الصحية، وترشيد شراء الأدوية والتجهيزات.
تنسيق الفاعلين	تنظيم التعاون بين المستشفى، العيادات الجوارية، الضمان الاجتماعي، والقطاع الخاص ضمن مسار واحد للمريض.
مواجهة الأمراض المستحثة	استهداف عوامل الخطر قبل تحولها إلى أمراض مزمنة أو مضاعفات مكلفة.

تاسعاً: تركيب المحاضرة

يمكن تلخيص منطق المحاضرة في العلاقة الآتية: إذا تغيرت بنية السكان وارتفع عبء الأمراض المزمنة والمستحثة، فإن النظام الصحي يصبح مطالباً بتغيير طريقة تنظيمه وتمويله وتوزيع موارده. فالاستجابة المستقبلية لا تكون فقط بزيادة العرض، بل بإعادة هيكلته: وقاية أقوى، رعاية أولية فعالة، إحالة منظمة، رقمنة، موارد بشرية

متوازنة، واستدامة مالية 2013؛ (Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Brahamia, 2023؛
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021)
ومن ثم، فإن رؤية 2030 ليست شعاراً زمنياً، بل إطاراً لتحويل النظام الصحي من نظام يتدخل غالباً بعد حدوث
المرض إلى نظام يتوقع المخاطر، يكتشفها مبكراً، ويتابعها باستمرار وبأقل تكلفة ممكنة على الدولة والمريض.
(Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 11-18، 2018)

عاشرًا: خلاصة المحاضرة

تؤكد هذه المحاضرة أن الفصل الثامن يقوم على مطلبين مترابطين: تحديد ملامح النظام الصحي المتوقع في أفق
2030، ثم تكييف عرض الرعاية الصحية مع آثار الشيخوخة وعبء الأمراض. ويدخل عنصر الأمراض المستحثة
ضمن المطلب الثاني لأنه يتعلق بنتائج التحولات الديموغرافية والوبائية ونمط الحياة على طبيعة الطلب الصحي.
(Korea Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 11-18، 2018)

ولا يمكن تحقيق نظام صحي عادل وفعال في أفق 2030 من دون ربط التخطيط الصحي بالتمويل المستدام،
والموارد البشرية الكافية، والتوزيع الجغرافي المنصف، والحوكمة القائمة على البيانات. وبذلك تختتم هذه المحاضرة
المسار العام للمقياس من خلال الانتقال من وصف النظام الصحي إلى التفكير في مستقبله وإصلاحه. (Korea
Development Institute & MOSF, 2013؛ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2021؛ القانون 11-18، 2018)

حادي عشر: حالة تطبيقية وأسئلة مرافقة

نص الحالة:

في إحدى الولايات الداخلية، تعاني فئة متزايدة من كبار السن من أمراض مزمنة متعددة مثل السكري وارتفاع
ضغط الدم وأمراض القلب. يضطر بعض المرضى إلى التنقل بانتظام نحو ولاية كبرى لإجراء فحوصات
متخصصة، كما تتكرر التحاليل بسبب غياب ملف طبي رقمي موحد بين المؤسسات. وتتحمل الأسر تكاليف النقل
والمرافقة وبعض الفحوصات في القطاع الخاص بسبب طول آجال الانتظار في القطاع العام.

أسئلة الحالة التطبيقية:

- حل هذه الحالة من زاوية الشيخوخة وارتفاع عبء الأمراض المزمنة والمستحثة.

- ما مظاهر ضعف تكييف عرض الرعاية الصحية مع حاجات السكان في هذه الحالة؟
- كيف يمكن أن تساهم رؤية 2030 في معالجة هذه الاختلالات؟
- اقترح إجراءات عملية لتحسين المسار العلاجي وتقليل التكاليف على المريض والأسرة.

ثاني عشر: الحل النموذجي المقترح

المحور	عناصر الإجابة النموذجية
تحليل الشيخوخة وعبء الأمراض	تعكس الحالة انتقال الطلب الصحي من علاج حالات حادة ومؤقتة إلى متابعة أمراض مزمنة متعددة لدى كبار السن . كما تبرز آثار الأمراض المستحثة أو المتفاقمة بفعل الشيخوخة ونمط الحياة، وهو ما يرفع الحاجة إلى متابعة دورية، أدوية مستمرة، فحوص منتظمة، ورعاية منسقة بين عدة تخصصات.
مظاهر ضعف عرض الرعاية	تظهر الاختلالات في اضطرار المرضى إلى التنقل نحو ولايات كبرى، طول آجال الانتظار، تكرار التحاليل، غياب ملف طبي رقمي، عدم كفاية الرعاية الجوارية والمتابعة القريبة من محل السكن، وضعف خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن.
دور رؤية 2030	تساهم رؤية 2030 عبر تقوية الرعاية الأولية، تعميم الرقمنة، تحسين الإحالة، توزيع الأخصائيين بشكل أكثر عدالة، تطوير برامج وقاية وكشف مبكر، وتوجيه التمويل نحو الخدمات التي تقلل المضاعفات والكلفة طويلة الأمد.
الإجراءات العملية	يمكن اقتراح إنشاء عيادات متابعة للأمراض المزمنة، تطوير طب الأسرة، اعتماد ملف طبي رقمي موحد، تنظيم الإحالة نحو الأخصائي، دعم الرعاية المنزلية لكبار السن، وتفعيل التعاقد المنظم مع القطاع الخاص عند الحاجة لتقليص الإنفاق من الجيب.

خاتمة المطبوعة

تخلص هذه المطبوعة إلى أن النظام الصحي الجزائري لم يتشكل دفعة واحدة، بل مر بمراحل تاريخية متتابعة فرضتها ظروف الاستقلال، وحاجات السكان، والاختيارات الاجتماعية للدولة، والتحول الديموغرافية والوبائية.

فقد انطلقت السياسة الصحية من معالجة إرث ثقيل تمثل في ضعف البنية التحتية، قلة الموارد البشرية، انتشار الأمراض المعدية، وتفاوت واضح في الوصول إلى الرعاية، ثم اتجهت تدريجياً نحو بناء نظام صحي عمومي يقوم على توسيع التغطية وتقريب الخدمات من المواطن.

لقد أظهرت المحاضرات الأولى أن فهم السياسات الصحية اللاحقة لا يمكن أن يتم دون العودة إلى وضعية الستينيات. فالاختلالات الأولى في الموارد والهياكل والتوزيع الجغرافي فسرت الحاجة إلى بناء سياسة صحية وطنية، كما فسرت اللجوء إلى التعاون الدولي وتوسيع التكوين الصحي. ومن هذا المنطلق جاءت مجانية العلاج سنة 1974 تعبيراً عن خيار اجتماعي هدفه إزالة الحاجز المالي أمام العلاج، لكنها كشفت أيضاً أن الحق في العلاج لا يتحقق بمجرد إقرار المجانية، بل يحتاج إلى عرض صحي كاف ومنظم وقريب من السكان.

كما أبرزت محاضرة الثمانينيات أن التوسع في الرعاية الأولية والوقاية كان خياراً تنظيمياً واقتصادياً أساسياً. فالوقاية والتلقيح وحماية الأمومة والطفولة ليست خدمات ثانوية، بل أدوات مركزية لتقليل عبء المرض وتخفيض تكاليف العلاج المستقبلية. ومن هنا يتضح أن كفاءة النظام الصحي تقاس بقدرته على منع المرض أو اكتشافه مبكراً، وليس فقط بقدرته على علاج الحالات المعقدة داخل المستشفيات الكبرى.

أما تحليل هيكل وتنظيم النظام الصحي فقد بين أن الهرم الصحي لا يمثل تقسيماً إدارياً بسيطاً، بل منطقاً وظيفياً يهدف إلى توجيه المريض نحو المستوى المناسب من الرعاية، وحماية المستشفيات الجامعية من الضغط غير المبرر، وترشيد استعمال الموارد النادرة. ويرتبط هذا التنظيم ارتباطاً وثيقاً بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لأن التمويل التضامني لا يمكن أن يكون مستداماً إذا لم يقابله استعمال عقلاني لمسار العلاج والتدرج بين مستويات الرعاية.

وفي مرحلة ما بعد 2007، أصبحت تحديات النظام الصحي أكثر تعقيداً بفعل التحول الديموغرافي والوبائي، وارتفاع الطلب على الرعاية المتخصصة، وبروز الأمراض المزمنة وغير السارية. وقد أبرزت المطبوعة أن هذه التحولات لا تطرح سؤال العلاج فقط، بل تطرح سؤال اللامركزية، وتوزيع الأخصائيين، وتنسيق القطاعين العام والخاص، وتطوير المسارات العلاجية بما يقلل من الانتظار والتكاليف غير المباشرة والإنفاق من الجيب.

وتؤكد محاضرتا الموارد البشرية والتمويل الصحي أن الإصلاح الصحي لا ينجح إذا عالج الهياكل بمعزل عن البشر والمال. فالطبيب والممرض والأخصائي والتقني والإداري الصحي يمثلون رأس مال بشرياً لا غنى عنه، وتوزيعهم غير المتوازن يضعف الإنصاف ويزيد كلفة الوصول إلى العلاج. وبالمثل، فإن نمو نفقات الصحة وارتفاع أسعار التكنولوجيا والأدوية، وتزايد الإنفاق المباشر من الجيب، كلها عوامل تجعل الاستدامة المالية والحماية المالية للأسر جزءاً لا يتجزأ من جودة النظام الصحي.

أما رؤية 2030 فتقدم أفقاً تركيبياً للمطبوعة كلها؛ فهي تدفع إلى التفكير في نظام صحي أكثر إنصافاً، جودة، رقمنة، وقابلية للاستدامة، وقادر على التكيف مع الشيخوخة وعبء الأمراض المزمنة والمستحثة عن التحولات الاجتماعية والوبائية. ولا يمكن لهذه الرؤية أن تتحقق إلا إذا تم الربط بين التخطيط الاستراتيجي، التمويل، الموارد البشرية، الرعاية الأولية، الوقاية، الرقمنة، وتنسيق الفاعلين ضمن مسار عالجي واضح يضع المريض في مركز النظام.

بناءً على ذلك، فإن الرسالة العامة لهذه المطبوعة هي أن النظام الصحي الجزائري يجب أن يفهم كمنظومة متكاملة لا كمجموعة قطاعات منفصلة. فكل قرار يتعلق بالتمويل يؤثر في الوصول إلى العلاج، وكل خلل في توزيع الموارد البشرية يؤثر في الإنصاف، وكل ضعف في الوقاية يزيد نفقات العلاج، وكل غياب للتنسيق يرفع العبء على المريض والدولة والضمان الاجتماعي. لذلك فإن دراسة هذا المقياس تمنح طالب الطب رؤية أوسع لدوره المستقبلي، ليس فقط كممارس علاجي، بل كفاعل في منظومة صحية تتطلب فهماً اقتصادياً واجتماعياً وتنظيماً متكاملاً.

قائمة المراجع النهائية

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2018). القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال 1439 الموافق 2 يوليو 2018، المتعلق بالصحة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 46، 29 يوليو 2018.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (1983). القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 28، 5 يوليو 1983.
- Brahamia, B. (2022). The Health Care System in Algeria. CRC 1342 Social Policy Country Briefs No. 28. Bremen: CRC 1342, University of Bremen
- Brahamia, B. (2023). Évolution et tendances des systèmes de santé: OCDE, pays d'Europe de l'Est Maghreb. Alphadoc Edit
- Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED). (2012). Systèmes de santé au Maghreb. Les Notes de l'IPEMED, n° 12
- Institut National de Santé Publique / Projet TAHINA. (2007). Transition épidémiologique et système de santé: Enquête nationale santé 2005. Alger: Institut National de Santé Publique
- Korea Development Institute & Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea. (2013) Establishment of Algeria's National Vision 2030. Seoul: Korea Development Institute / Ministry of Strategy and Finance
- Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. (2021). Santé en chiffres 2021. Alger: MSPRH